G4 — Fatigue, lassitude · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v1

LOT_004 audité · Phase A + Phase B (DX.1–11) · 88 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 52 EX · 20 AP · 16 SPE

🧭 Carte mentale G4 · 60 secondes avant de répondre

EX **Examen** — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

AP **Approfondissement** — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

SPE · spécialité **Spécialiste** — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

Les 3 questions réflexes devant toute fatigue

1. **Danger maintenant ?** Idées suicidaires, douleur thoracique, syncope, instabilité, polyurie-polydipsie → **urgence, glycémie capillaire, ECG**.
2. **Signe d'appel ?** Perte de poids, fièvre, sueurs, adénopathie, saignement, déficit neurologique → **bilan ciblé, imagerie, avis**.
3. **Sinon :** anamnèse (humeur, sommeil, médicaments), examen complet, **bilan de base limité** (NFS, CRP, glycémie, TSH, ferritine, créatinine, ALAT) ; revoir à 4–6 semaines.

🧠 Psychique · sommeil

- PHQ-2 ≥ 3 → PHQ-9 ; ≥ 10 dépiste, ≥ 16 forme plus sévère (DX.1)
- TAG : ≥ 6 mois, ≥ 3/6 symptômes ; panique : attaques récurrentes + 1 mois (DX.8)
- Epworth, STOP-Bang ≥ 3 → polysomnographie ; TCC-I d'abord (DX.3)

🩸 Biologie de base

- Hb < 120 (F) / < 130 (H) → VGM, ferritine (DX.6) ; ferritine < 50 + Hb normale chez la femme réglée → fer oral
- HbA1c ≥ 6,5 % ou GAJ ≥ 7,0 → 2e test (DX.4)
- TSH 4–10 → répéter 2–3 mois ; > 10 → traiter avant 65–70 ans (DX.9)

⏳ Durée · effort

- Après infection : < 6 sem = convalescence (DX.10)
- ≥ 6 sem + PEM, sommeil non réparateur, cognition → soupçon SFC ; 3 mois → diagnostic (DX.7)
- Pacing ; jamais d'exercice gradué fixe

🦴 Locomoteur · organe

- Ceintures > 50 ans, raideur > 45 min → CRP, VS (DX.2)
- Céphalée temporale, trouble visuel → corticoïde immédiat
- Signe d'organe → bilan de l'organe (DX.5) ; histologie pour le cancer (DX.11)

🚩 Ordre d'exclusion

1. E1 Dépression avec risque suicidaire (DX.1)
2. E2 Diabète décompensé (DX.4)
3. E3 Maladie somatique grave (DX.5)
4. E4 Anémie sévère (DX.6)
5. E5 Néoplasie maligne (DX.11)
6. Puis : sommeil, musculo-squelettique, anxiété, hypothyroïdie, post-infectieux, SFC

Bilan de base normal ≠ cancer exclu. Méta-analyse : dépression 18,5 %, maladie grave 4,3 %, anémie 2,8 %, cancer 0,6 %.

① Raisonner · 24 Q · avant de nommer le diagnostic

Drapeau rouge d'abord (suicide, glycémie, perte de poids, saignement, instabilité). Sinon : anamnèse, examen, bilan de base limité, puis humeur et sommeil.

Q1 **EX** **DX.5 · bilan sans signe d'appel** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 38 ans consulte pour une fatigue depuis 2 mois. Pas de perte de poids, pas de fièvre, pas de saignement. L'examen clinique complet est normal ; poids stable. Elle travaille à plein temps et dort 7 heures.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** TDM thoraco-abdominale pour exclure un cancer
- **B** Dosage des marqueurs tumoraux
- **C** Bilan de base limité
- **D** Polysomnographie d'emblée
- **E** Sérologies virales étendues et dépistage cœliaque

Q2 **EX** **DX.1 · bilan normal** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 44 ans, comptable, est fatigué depuis 3 mois. Il dit « ne plus avoir goût à rien » depuis le décès de son père. Examen normal ; NFS, CRP, glycémie, TSH et ferritine normales.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** PHQ-2, puis PHQ-9 et entretien clinique
- **B** TDM cérébrale
- **C** Dosage du cortisol à 9 h
- **D** Polygraphie respiratoire nocturne
- **E** Répéter le même bilan sanguin dans 1 mois

Q3 **EX** **DX.1 🚩E1 · idées suicidaires** Prise en charge · cabinet

Une femme de 51 ans, suivie pour fatigue, a un PHQ-9 à 21. À la question directe, elle dit avoir pensé à « en finir » et avoir mis de côté ses comprimés. Elle est venue seule.

Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?

- **A** Débuter sertraline 50 mg et la revoir dans 2 semaines
- **B** Prescrire une psychothérapie et un arrêt de travail
- **C** Ne pas la laisser seule, avis psychiatrique urgent
- **D** Compléter d'abord le bilan somatique de la fatigue
- **E** Lui demander de rappeler si les idées persistent

Q4 **EX** **DX.4 🚩E2 · polyurie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 29 ans se plaint d'une fatigue intense depuis 3 semaines. Il urine la nuit plusieurs fois, a très soif et a perdu 5 kg sans régime. Il a des nausées depuis hier.

Quel examen faut-il réaliser en premier ?

- **A** TSH et fT4
- **B** HbA1c au laboratoire dans la semaine
- **C** Ferritine et NFS
- **D** Glycémie capillaire immédiate
- **E** Échelle d'Epworth

Q5 **EX** **DX.11 🚩E5 · perte de poids** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 67 ans, ancien fumeur, est fatigué depuis 2 mois. Il a perdu 6 kg sans régime et transpire la nuit. L'examen trouve un ganglion sus-claviculaire dur de 2 cm. NFS, CRP et TSH normales.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Réévaluation clinique à 4 à 6 semaines
- **B** Dépistage de la dépression par PHQ-9
- **C** Antibiothérapie d'épreuve pour adénite
- **D** Imagerie ciblée et avis spécialisé rapide
- **E** Dosage des marqueurs tumoraux pour décider

Q6 **EX** **DX.6 · fer sans anémie** Prise en charge · cabinet

Une femme de 35 ans, réglée, se plaint de fatigue depuis 4 mois. Examen normal. Hb 132 g/L, ferritine 22 µg/L, CRP normale. TSH et glycémie normales.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Aucun traitement, car l'Hb est normale
- **B** Carboxymaltose ferrique IV d'emblée
- **C** Transfusion d'un concentré érythrocytaire
- **D** Gastroscopie et coloscopie avant tout traitement
- **E** Fer oral, contrôle à 6 semaines

Q7 **EX** **DX.9 · TSH limite chez l'âgé** Prise en charge · cabinet

Un homme de 75 ans se plaint de fatigue. TSH 6 mU/L, fT4 normale. Pas de goitre, pas de cardiopathie. Le reste du bilan de base est normal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Pas de traitement hormonal
- **B** Lévothyroxine 25 µg/j
- **C** Lévothyroxine 100 µg/j
- **D** Échographie thyroïdienne urgente
- **E** Liothyronine en association

Q8 **EX** **DX.7 · 4 symptômes à 3 mois** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 34 ans, infirmière, est épuisée depuis 4 mois. Chaque effort (courses, garde) l'« écrase » le surlendemain pendant plusieurs jours. Sommeil non réparateur, difficultés à trouver ses mots. Humeur conservée, plaisir intact. Examen et bilan de base normaux.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Syndrome de fatigue chronique
- **B** Épisode dépressif caractérisé
- **C** Insomnie chronique
- **D** Fibromyalgie
- **E** Trouble anxieux généralisé

Q9 **EX** **DX.3 vs DX.7 · somnolence** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 52 ans, IMC 34, se dit « toujours fatigué ». Il s'endort en lisant et a failli s'assoupir au volant. Son épouse rapporte des ronflements et des pauses respiratoires. PA 152/94 mmHg.

Quelle démarche est la plus appropriée ?

- **A** Prescrire du zolpidem 10 mg pour améliorer le sommeil
- **B** Bilan de base et réévaluation à 3 mois
- **C** TCC-I en première intention
- **D** Évoquer un syndrome de fatigue chronique
- **E** Interdire la conduite et demander une polysomnographie

Q10 **EX** **DX.10 · convalescence** Prise en charge · cabinet

Un homme de 27 ans a eu une infection virale des voies respiratoires il y a 3 semaines. La fièvre a disparu depuis 15 jours, mais il reste fatigué. Pas de dyspnée, pas de douleur thoracique. Examen et constantes normaux.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Poser le diagnostic de syndrome de fatigue chronique
- **B** Programme d'exercice gradué à paliers fixes
- **C** Sérologies EBV et CMV étendues
- **D** Arrêt de travail de 3 mois d'emblée
- **E** Rassurer, gérer l'énergie, revoir

Q11 **EX** **DX.2 · douleur des ceintures** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 72 ans est fatiguée depuis 6 semaines. Elle a des douleurs des deux épaules et des hanches, avec une raideur matinale d'environ 1 heure. Pas de céphalée, pas de trouble visuel. Pas de synovite périphérique.

Quel examen faut-il demander en premier ?

- **A** IRM des épaules
- **B** CRP et vitesse de sédimentation
- **C** Critères ACR 2016 de fibromyalgie
- **D** Biopsie de l'artère temporale d'emblée
- **E** Électromyogramme

Q12 **EX** **DX.8 · palpitations** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 31 ans arrive aux urgences pour des épisodes de palpitations, sueurs et peur de mourir. Elle est épuisée et dort mal depuis des semaines. FC 104/min, PA 128/80 mmHg. Pas de traitement connu.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Lorazépam 1 mg sublingual et retour à domicile
- **B** Hospitalisation en psychiatrie
- **C** ECG, TSH, glycémie, électrolytes et hémogramme
- **D** ISRS et TCC d'emblée
- **E** Holter de 24 h en ambulatoire

Q13 **EX** **DX.4 · confirmer** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 58 ans, asymptomatique, consulte pour une fatigue modérée. HbA1c 6,7 % sur un premier bilan. IMC 29 kg/m². Hb normale, DFGe 78.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Retenir le diabète et débuter la metformine
- **B** Classer d'emblée en diabète de type 1 par auto-anticorps
- **C** Mesure continue du glucose pour poser le diagnostic
- **D** Confirmer par un second test un autre jour
- **E** Conclure à un prédiabète

Q14 **EX** **DX.6 vs DX.11 · homme ferriprive** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 62 ans se plaint de fatigue et d'essoufflement à l'effort. Hb 104 g/L, VGM 74 fL, ferritine 8 µg/L. Pas de saignement visible. Alimentation variée.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Fer oral seul et contrôle dans 3 mois
- **B** Rechercher un saignement digestif
- **C** Dosage de la B12 et des folates
- **D** Frottis et ponction médullaire
- **E** Transfusion de 2 concentrés

Q15 **EX** **DX.11 🚩 · hypercalcémie maligne** Prise en charge · urgences

Une femme de 64 ans suivie pour un cancer du sein est confuse, très assoiffée et constipée depuis 5 jours. Calcium corrigé par l'albumine 3,4 mmol/L, créatinine en hausse. PA 102/64 mmHg.

Quelle est la première mesure thérapeutique ?

- **A** Acide zolédronique 4 mg IV immédiat, sans perfusion préalable
- **B** Dexaméthasone à haute dose
- **C** Hydratation IV, puis acide zolédronique 4 mg
- **D** Furosémide IV en première intention
- **E** Calcium total de contrôle avant toute décision

Q16 **EX** **DX.9 · TSH élevée isolée** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 40 ans, sans projet de grossesse, se plaint de fatigue. TSH 6,2 mU/L, fT4 normale. Pas de goitre. Le reste du bilan est normal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Lévothyroxine 50 µg/j
- **B** Échographie thyroïdienne
- **C** IRM hypophysaire
- **D** Conclure que la TSH explique la fatigue
- **E** Répéter TSH, fT4 et anti-TPO à 2–3 mois

Q17 **EX** **DX.1 · avant l'antidépresseur** Prise en charge · cabinet

Un homme de 33 ans a un épisode dépressif caractérisé, PHQ-9 à 18. Il raconte qu'il y a 2 ans, il a dormi 3 heures par nuit pendant une semaine, « plein d'énergie », et a dépensé toutes ses économies.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Sertraline 50 mg/j et contrôle à 2 semaines
- **B** Avis psychiatrique, pas d'antidépresseur seul
- **C** Escitalopram 10 mg/j
- **D** Benzodiazépine au long cours
- **E** Thérapie guidée seule, car la forme est légère

Q18 **EX** **DX.3 · insomnie chronique** Prise en charge · cabinet

Une femme de 46 ans a du mal à s'endormir et se réveille à 4 h, 4 nuits par semaine depuis 5 mois. Elle est fatiguée et irritable au travail. Pas de ronflement ; humeur conservée ; PHQ-2 à 1. Elle a 8 heures pour dormir.

Quel est le traitement de première intention ?

- **A** Zolpidem 10 mg pendant 3 mois
- **B** TCC-I, en personne ou en ligne
- **C** Mélatonine Circadin® 2 mg
- **D** Témazépam 20 mg au long cours
- **E** Antihistaminique sédatif

Q19 **EX** **DX.2 🚩 · artérite** Prise en charge · cabinet

Un homme de 76 ans est fatigué depuis 1 mois. Il décrit une céphalée temporale nouvelle et une douleur de la mâchoire en mastiquant. Hier, il a vu flou de l'œil droit pendant quelques minutes. CRP 68 mg/L.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Biopsie de l'artère temporale, puis traitement selon le résultat
- **B** Prednisone 15 mg/j, comme pour une polymyalgie
- **C** AINS et contrôle de la CRP à 1 semaine
- **D** IRM cérébrale avant tout traitement
- **E** Glucocorticoïde à haute dose sans délai, avis dans les 24 h

Q20 **EX** **DX.10 🚩 · rate** Prise en charge · urgences

Un étudiant de 19 ans a une mononucléose diagnostiquée il y a 2 semaines. Il est fatigué et consulte pour une douleur brutale du flanc gauche, sans traumatisme. FC 118/min, PA 98/60 mmHg.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Antalgique et contrôle à 48 h
- **B** Échographie abdominale ambulatoire dans la semaine
- **C** Appeler le 144, avis chirurgical
- **D** Sérologie EBV de contrôle
- **E** Rassurer : fatigue post-infectieuse

Q21 **EX** **DX.8 · TAG** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 39 ans se dit épuisée depuis 8 mois. Elle s'inquiète « de tout » (travail, enfants, argent) sans pouvoir s'arrêter, se sent tendue, irritable, dort mal et se concentre difficilement. Humeur et plaisir conservés. TSH et glycémie normales.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Trouble panique
- **B** Épisode dépressif caractérisé
- **C** Syndrome de fatigue chronique
- **D** Phobie sociale
- **E** Trouble anxieux généralisé

Q22 **AP** **DX.4 · mécanisme** Mécanismes · cabinet

Une femme de 49 ans a un diabète de type 2 nouvellement découvert, glycémie à jeun 9,8 mmol/L. Elle demande pourquoi elle est si fatiguée alors que « son sang est plein de sucre ».

Quel mécanisme explique le mieux sa fatigue ?

- **A** Les cellules manquent de glucose malgré l'hyperglycémie
- **B** Les cytokines inflammatoires induisent un comportement de maladie
- **C** Le transport d'oxygène est réduit
- **D** Le métabolisme basal est ralenti par déficit hormonal
- **E** La neurotransmission sérotoninergique est déréglée

Q23 **AP** **DX.5 · interpréter la fréquence** Mécanismes · cabinet

Un médecin de famille lit que 4,3 % des consultants pour fatigue ont une maladie somatique grave. Il hésite à prescrire une imagerie large à tous ses patients fatigués sans signe d'appel.

Quelle interprétation de cette donnée est la plus juste ?

- **A** La fréquence est identique chez les patients non fatigués
- **B** La fatigue multiplie par 4 le risque de maladie grave
- **C** Un bilan large systématique est donc recommandé
- **D** La dépression est plus rare que la maladie grave
- **E** Un bilan de routine normal exclut une maladie grave

Q24 EX DX.5 🚩E3 · surrénale Prise en charge · urgences

Une femme de 45 ans est amenée aux urgences pour fatigue extrême, vomissements et malaise debout. PA 82/50 mmHg, FC 120/min. Natrémie 128 mmol/L, kaliémie 5,8 mmol/L. Peau hyperpigmentée.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attendre le résultat du cortisol avant tout traitement
- **B** Cortisol à 9 h en ambulatoire, puis décision
- **C** Restriction hydrique pour l'hyponatrémie
- **D** Méthylprednisolone en premier choix
- **E** Hydrocortisone IV sans attendre le cortisol

② Discriminer · 50 Q · un signe, un examen qui tranche

Les 11 DX du LOT face à face : un signe, un examen qui tranche, une conduite. Les questions AP (bleu) et SPE (violet) sont mêlées aux EX : filtrez par niveau en haut.

Q25 EX DX.1 vs DX.8 · DX.7 Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 47 ans est fatiguée depuis 3 semaines. Elle est triste presque chaque jour, ne prend plus plaisir à rien, dort mal, se sent coupable et ne se concentre plus ; elle a réduit son temps de travail. TSH, NFS et ferritine normales.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Trouble anxieux généralisé
- **B** Syndrome de fatigue chronique
- **C** Épisode dépressif caractérisé
- **D** Insomnie chronique
- **E** Fatigue post-infectieuse

Q26 **EX** **DX.1 · forme moins sévère** Prise en charge · cabinet

Un homme de 36 ans a un épisode dépressif caractérisé, PHQ-9 à 12. Pas d'idée suicidaire, pas d'antécédent de manie, pas de substance. Il préfère éviter les médicaments.

Quelle prise en charge est la plus appropriée ?

- **A** ISRS d'emblée, car toute dépression se traite par médicament
- **B** Thérapie guidée, activité physique et réévaluation à 2 semaines
- **C** Hospitalisation psychiatrique
- **D** Benzodiazépine pour améliorer le sommeil
- **E** Électroconvulsivothérapie

Q27 **AP** **DX.1 · ISRS** Prise en charge · cabinet

Une femme de 42 ans a un épisode dépressif, PHQ-9 à 19, sans idée suicidaire ni antécédent de manie. Elle accepte une TCC et un antidépresseur ; vous choisissez la sertraline (Zoloft®). Fonction hépatique normale.

Quel schéma correspond à l'AIPS ?

- **A** 25 mg/j, augmenter de 25 mg tous les 2 jours
- **B** 100 mg/j d'emblée, maximum 400 mg
- **C** 50 mg/j pendant 4 semaines, puis arrêt brutal du traitement
- **D** 200 mg/j d'emblée pour un effet plus rapide
- **E** 50 mg/j ; +50 mg/semaine au plus ; maximum 200 mg

Q28 **SPE · Psychiatrie** **DX.1 · durée et suivi** Prise en charge · cabinet

Un homme de 22 ans débute un ISRS pour un épisode dépressif modéré. Il n'a pas de plan suicidaire mais des pensées de mort passives.

Quand faut-il le revoir pour la première réévaluation ?

- **A** Dans 1 semaine
- **B** Dans 2 semaines, comme tout patient
- **C** Dans 4 semaines, quand l'effet apparaît
- **D** Dans 3 mois
- **E** Seulement en cas d'aggravation

Q29 **SPE · Psychogériatrie** **DX.1 · sujet âgé** Prise en charge · EMS

Une résidente d'EMS de 78 ans, fatiguée et triste depuis 2 mois, a un épisode dépressif modéré. Le psychiatre de liaison propose l'escitalopram (Cipralex®).

Quel schéma et quelle surveillance correspondent à l'AIPS ?

- **A** 5 mg au départ, maximum 10 mg ; natrémie au début
- **B** 10 mg au départ, maximum 20 mg ; pas de contrôle
- **C** 20 mg d'emblée ; ECG annuel
- **D** 5 mg au départ ; arrêt brutal dès l'amélioration
- **E** Dose adulte ; surveiller le poids à chaque visite

Q30 **EX** **DX.2 vs DX.1 · fibromyalgie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 45 ans a des douleurs diffuses dans les 4 membres et le rachis depuis 8 mois, avec fatigue et sommeil non réparateur. Examen articulaire sans synovite. NFS, CRP, VS, CK et TSH normales. Humeur conservée.

Sur quoi repose le diagnostic de fibromyalgie ?

- **A** Nombre de points douloureux à la pression digitale
- **B** Un bilan biologique normal suffit
- **C** Une CRP élevée
- **D** Indice de douleur diffuse et score de sévérité
- **E** L'absence de toute autre maladie

Q31 **EX** **DX.2 · fibromyalgie, traitement** Prise en charge · cabinet

La même patiente de 45 ans a une fibromyalgie confirmée. Elle demande « le médicament le plus efficace » pour sa fatigue et ses douleurs.

Quelle mesure a le niveau de recommandation le plus fort ?

- **A** Prégabaline (Lyrica®)
- **B** Glucocorticoïde à faible dose
- **C** Repos prolongé
- **D** AINS au long cours
- **E** Exercice aérobie régulier

Q32 **SPE · Rhumatologie** **DX.2 · doses EULAR** Prise en charge · cabinet

Une femme de 70 ans a une polymyalgie rhumatismale typique, sans céphalée ni trouble visuel. CRP 42 mg/L. Le rhumatologue confirme et vous demande de débuter le traitement.

Quelle dose initiale de glucocorticoïde l'EULAR propose-t-elle ?

- **A** 40 à 60 mg/j d'équivalent prednisone
- **B** 15 à 25 mg/j, puis décroissance
- **C** 5 mg/j au long cours sans décroissance
- **D** Paracétamol seul, sans glucocorticoïde
- **E** AINS seuls

Q33 **AP** **DX.2 · classification** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un médecin assistant calcule un score EULAR/ACR 2012 de 5 chez une patiente de 68 ans avec douleur des épaules et CRP élevée, et conclut : « diagnostic posé ».

Quelle remarque est la plus juste ?

- **A** Le diagnostic exige un score de 8
- **B** Le score exige une biopsie temporale positive
- **C** Un facteur rhumatoïde positif est requis
- **D** Ils classent, sans poser le diagnostic
- **E** La raideur matinale ne compte pas

Q34 **EX** **DX.3 · sommeil insuffisant** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 30 ans, développeur, se dit fatigué. Son agenda du sommeil montre 5 heures par nuit par choix (séries tardives), sans difficulté à s'endormir. Le week-end, il dort 9 heures et va mieux.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Insomnie chronique
- **B** Syndrome d'apnées obstructives du sommeil
- **C** Sommeil insuffisant
- **D** Épisode dépressif caractérisé
- **E** Syndrome de fatigue chronique

Q35 **AP** **DX.3 · hypnotique** Prise en charge · cabinet

Une femme de 72 ans souffre d'insomnie malgré une TCC-I bien conduite. Vous envisagez un hypnotique à court terme. Pas d'apnées.

Quel schéma correspond à l'AIPS ?

- **A** Zolpidem 10 mg pendant 3 mois
- **B** Témazépam 20 mg en continu
- **C** Mélatonine à libération rapide
- **D** Antipsychotique sédatif à faible dose
- **E** Zolpidem 5 mg, 4 semaines au plus

Q36 **SPE · Médecine du sommeil** **DX.3 · daridorexant** Prise en charge · cabinet

Un homme de 54 ans a une insomnie chronique depuis 1 an, échec d'une TCC-I. Le spécialiste du sommeil propose le daridorexant (Quviviq®). Pas d'insuffisance hépatique.

Quel schéma correspond à l'AIPS ?

A 10 mg le soir, maximum 4 semaines

B 50 mg le soir ; revoir dans 3 mois

C 2 mg dès 55 ans

D 25 mg trois fois par jour pendant les repas

E 50 mg le matin au réveil

Q37 **AP** **DX.3 · SAOS, sévérité** Évaluation / diagnostic · policlinique

La polysomnographie d'un homme de 58 ans, somnolent, montre un IAH de 34 événements par heure.

Comment classer ce résultat ?

A SAOS léger

B Examen normal

C Insomnie chronique

D SAOS modéré

E SAOS sévère

Q38 **EX** **DX.4 · metformine et rein** Prise en charge · cabinet

Un homme de 71 ans a un diabète de type 2 nouvellement confirmé. DFGe 26 mL/min/1,73 m². Il n'a pas de maladie cardiovasculaire connue.

Quelle affirmation sur la metformine est juste ?

- **A** Elle est contre-indiquée à ce DFGe
- **B** Elle débute à 500 mg/j et monte jusqu'à 3000 mg
- **C** Elle est possible à 1000 mg/j au maximum
- **D** Elle se contrôle simplement tous les 6 mois
- **E** Elle remplace l'insuline dans le type 1

Q39 **EX** **DX.4 · HbA1c faussée** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 39 ans, fatiguée, a une anémie hémolytique connue. Son HbA1c est de 5,1 %, mais elle a soif et urine beaucoup depuis 2 semaines.

Quel examen faut-il utiliser pour le diagnostic ?

- **A** Une nouvelle HbA1c dans 3 mois
- **B** Une glycémie capillaire isolée
- **C** La mesure continue du glucose
- **D** La glycémie veineuse
- **E** Le peptide C

Q40 **SPE · Endocrinologie** **DX.4 · SGLT2** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 56 ans, diabétique de type 2 sous empagliflozine (Jardiance®), vomit depuis 24 heures. Il est épuisé et respire amplement. Glycémie 12 mmol/L.

Quel diagnostic faut-il évoquer en premier ?

- **A** Gastro-entérite virale simple
- **B** État hyperosmolaire hyperglycémique
- **C** Hypoglycémie sévère
- **D** Acidocétose euglycémique
- **E** Diabète bien équilibré

Q41 **SPE · Médecine intensive** **DX.4 · acidocétose, potassium** Prise en charge · urgences

Une femme de 23 ans, diabétique de type 1, est en acidocétose : β-OHB 4,8 mmol/L, pH 7,18. Le remplissage par NaCl 0,9 % a débuté. Kaliémie 3,1 mmol/L.

Quelle est la conduite la plus appropriée pour l'insuline ?

- **A** Débuter l'insuline IV immédiatement
- **B** Bicarbonate IV avant l'insuline
- **C** Insuline sous-cutanée et retour à domicile
- **D** Ajouter du glucose 5 % d'emblée
- **E** Retarder l'insuline et donner du potassium

Q42 **AP** **DX.4 · hypoglycémie** Prise en charge · domicile

Un homme de 66 ans, diabétique sous insuline, est retrouvé inconscient par son épouse. Glycémie capillaire 1,9 mmol/L. Pas d'accès veineux disponible.

Quelle est la première mesure ?

- **A** Sucre par voie orale
- **B** Glucagon 1 mg SC ou IM
- **C** Attendre l'ambulance sans traitement
- **D** Insuline rapide
- **E** Metformine 500 mg

Q43 **EX** **DX.5 · insuffisance cardiaque** Évaluation / diagnostic · EMS

Un résident d'EMS de 83 ans est de plus en plus fatigué depuis 1 mois. Il dort avec 3 oreillers. Œdèmes des chevilles, crépitants aux deux bases, galop à l'auscultation.

Quel examen confirme le mieux l'hypothèse principale ?

- **A** TSH et fT4
- **B** NT-proBNP et échocardiographie
- **C** PHQ-9
- **D** Ferritine et NFS, puis réévaluation
- **E** Polysomnographie

Q44 **EX** **DX.5 · endocardite** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 54 ans, porteur d'une valve aortique mécanique, est fatigué depuis 3 semaines, avec une fébricule le soir. Vous entendez un souffle nouveau.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Antibiothérapie orale d'épreuve pendant 7 jours
- **B** Réévaluation dans 4 à 6 semaines
- **C** Hémocultures, puis échocardiographie
- **D** Sérologies virales
- **E** PHQ-9 et entretien

Q45 **AP** **DX.5 · résultat isolé** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 41 ans, fatiguée depuis 6 semaines, sans signe d'appel, a un bilan de base normal sauf une CRP à 7 mg/L (norme < 5). Examen normal.

Quelle interprétation est la plus appropriée ?

- **A** Répéter et corréler à la clinique
- **B** La CRP élevée explique à elle seule la fatigue
- **C** TDM thoraco-abdominale pour exclure un cancer
- **D** Biopsie ostéomédullaire
- **E** Antibiothérapie empirique

Q46 **SPE · Endocrinologie** **DX.5 · relais oral** Prise en charge · hôpital

Une femme de 45 ans a été traitée pour une crise surrénalienne par hydrocortisone IV. Elle est stable. L'endocrinologue organise le relais pour une insuffisance surrénale chronique.

Quel schéma oral correspond à l'AIPS ?

- **A** Méthylprednisolone en premier choix
- **B** Hydrocortisone 100 mg/j au long cours
- **C** Aucun traitement une fois la crise passée
- **D** Hydrocortisone orale 10 à 20 mg/j
- **E** Hydrocortisone IV à haute dose prolongée

Q47 **EX** **DX.6 · macrocytaire** Prise en charge · cabinet

Une femme de 70 ans, fatiguée, a des paresthésies des pieds et une marche instable. Hb 98 g/L, VGM 112 fL.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Acide folique seul d'emblée
- **B** Fer oral
- **C** Doser B12, folates et MMA
- **D** Transfusion
- **E** Agent stimulant l'érythropoïèse

Q48 **SPE · Hématologie** **DX.6 · hémolyse** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 34 ans est fatigué depuis 10 jours, avec un ictère et des urines foncées. Hb 96 g/L, VGM 92 fL, réticulocytes élevés. Pas de saignement.

Quels examens confirment le mieux l'hypothèse principale ?

- **A** Ferritine et TSAT
- **B** Endoscopie digestive haute
- **C** LDH, haptoglobine, frottis
- **D** B12 et folates
- **E** Ponction médullaire d'emblée

Q49 **AP** **DX.6 · Ferinject®** Prise en charge · policlinique

Une femme de 28 ans, enceinte de 9 semaines, a une anémie ferriprive avec intolérance digestive au fer oral.

Quelle affirmation sur le carboxymaltose ferrique (Ferinject®) est juste ?

- **A** Il est indiqué en première intention au 1er trimestre
- **B** Il est contre-indiqué au 1er trimestre
- **C** La dose maximale est de 2000 mg par semaine
- **D** Il s'associe utilement au fer oral
- **E** Aucune surveillance n'est nécessaire après la dose

Q50 **AP** **DX.6 · transfusion** Prise en charge · hôpital

Un homme de 68 ans, hospitalisé et stable, sans cardiopathie, a une Hb de 76 g/L après un saignement digestif contrôlé par endoscopie. Il est asymptomatique au repos.

Quel seuil guide la décision transfusionnelle ?

- **A** Seuil restrictif de 70 à 80 g/L
- **B** Transfuser dès que l'Hb est sous 120 g/L
- **C** Transfuser seulement sous 50 g/L
- **D** Transfuser jusqu'à 130 g/L
- **E** Fer IV à la place de toute transfusion

Q51 **EX** **DX.7 vs DX.1 · PEM** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 41 ans est fatigué depuis 5 mois. Il dit ne plus avoir envie de rien et se sentir sans valeur ; un effort ne l'épuise pas davantage les jours suivants. Sommeil perturbé. Bilan de base normal.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- **A** Épisode dépressif caractérisé
- **B** Syndrome de fatigue chronique
- **C** Fatigue post-infectieuse
- **D** Fibromyalgie
- **E** Hypothyroïdie

Q52 **AP** **DX.7 · référentiels** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une patiente a les 4 symptômes NICE depuis 4 mois. Le consensus D-A-CH (2024) recommande les critères canadiens pour la suite de la prise en charge.

Quelle durée minimale ces critères canadiens exigent-ils chez l'adulte ?

- **A** 6 semaines
- **B** 6 mois
- **C** 3 mois
- **D** 2 semaines
- **E** 12 mois

Q53 **SPE · Médecine interne** **DX.7 · orthostatisme** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 26 ans avec syndrome de fatigue chronique se plaint d'étourdissements debout. Vous réalisez un test debout de 10 minutes : la FC passe de 72 à 108/min, sans hypotension.

Comment interpréter ce test ?

- **A** Tachycardie orthostatique posturale (POTS)
- **B** Test normal
- **C** Hypotension orthostatique
- **D** Insuffisance surrénalienne
- **E** Arythmie à explorer d'abord par un Holter de 24 h

Q54 **AP** **DX.7 · pharmacologie** Prise en charge · domicile

Une femme de 37 ans avec syndrome de fatigue chronique modéré a des douleurs musculaires. Elle a déjà mal toléré plusieurs médicaments.

Quel principe de prescription est le plus approprié ?

- **A** Débuter à pleine dose pour un effet rapide
- **B** Prescrire un traitement curatif du syndrome
- **C** Commencer à faible dose et augmenter lentement
- **D** Suppléments à haute dose
- **E** Méthylphénidate contre la fatigue

Q55 **EX** **DX.8 · trouble panique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 28 ans a eu 4 attaques brutales en 2 mois (palpitations, sueurs, tremblements, peur de mourir), sans déclencheur. Depuis, il craint la prochaine et évite les transports. ECG, TSH, glycémie et électrolytes normaux.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Trouble anxieux généralisé
- **B** Trouble panique
- **C** Attaque de panique isolée
- **D** Phobie spécifique
- **E** Épisode dépressif caractérisé

Q56 **EX** **DX.8 · TAG, première ligne** Prise en charge · cabinet

Une femme de 39 ans a un TAG avec retentissement marqué, sans amélioration après auto-aide guidée. Elle demande « un calmant ».

Quelle prise en charge est la plus appropriée ?

- **A** Lorazépam au long cours
- **B** TCC ou ISRS/IRSN
- **C** Antipsychotique à faible dose
- **D** Hydroxyzine en traitement de fond
- **E** Simple suivi sans traitement

Q57 **SPE · Psychiatrie** **DX.8 · prégabaline** Prise en charge · cabinet

Un homme de 50 ans a un TAG ; il n'a toléré ni l'escitalopram ni la venlafaxine. Clairance de la créatinine 90 mL/min. Le psychiatre propose la prégabaline (Lyrica®).

Quel schéma correspond à l'AIPS ?

- **A** 150 mg/j, jusqu'à 600 mg
- **B** 10 mg/j, maximum 20 mg
- **C** 75 mg/j au départ, maximum 225 mg/j
- **D** 50 mg/j, maximum 100 mg
- **E** 1 mg 2 à 3 fois/j

Q58 **SPE · Psychiatrie** **DX.8 · grossesse** Prise en charge · cabinet

Une femme de 31 ans, anxieuse, envisage une grossesse. Elle prend de la paroxétine (Deroxat®) depuis peu et demande si elle peut continuer ou passer à l'hydroxyzine (Atarax®).

Quelle affirmation correspond à l'AIPS ?

- **A** Deroxat® est le premier choix chez la femme qui envisage une grossesse
- **B** Atarax® est le premier choix pendant l'allaitement
- **C** Temesta® est sûr au 1er trimestre
- **D** Atarax® est contre-indiqué pendant la grossesse
- **E** Les ISRS n'ont aucun risque après 20 semaines

Q59 **EX** **DX.9 · forme manifeste** Prise en charge · cabinet

Une femme de 52 ans, frileuse, constipée, fatiguée, a une peau sèche et des réflexes lents. TSH 38 mU/L, fT4 basse. Pas de cardiopathie.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Répéter la TSH dans 2 à 3 mois avant de traiter
- **B** Lévothyroxine 25 à 50 µg/j, TSH à 2 mois
- **C** Lévothyroxine 200 µg/j d'emblée
- **D** Liothyronine en association
- **E** IRM hypophysaire

Q60 EX DX.9 · TSH > 10 Prise en charge · cabinet

Un homme de 48 ans, peu symptomatique, a une TSH de 13 mU/L contrôlée à 3 mois, fT4 normale, anti-TPO positifs. Pas de cardiopathie.

Quelle conduite l'ETA 2013 recommande-t-elle ?

A Surveiller sans traiter, car il est peu symptomatique

B Traiter par lévothyroxine

C Traiter seulement si la TSH dépasse 20 mU/L

D Ajouter la liothyronine

E Répéter tous les 2 à 3 mois indéfiniment

Q61 AP DX.9 · interactions Prise en charge · cabinet

Une femme de 60 ans sous lévothyroxine prend aussi du carbonate de calcium et du fer. Sa TSH remonte malgré une bonne observance.

Quel conseil est le plus approprié ?

A Prendre la lévothyroxine au repas avec le calcium

B Doubler la dose de lévothyroxine sans autre changement

C Arrêter définitivement le calcium

D Prendre la lévothyroxine le soir avec le fer

E Prendre la lévothyroxine au moins 2 h avant fer et calcium

Q62 **SPE · Endocrinologie** **DX.9 · hypothyroïdie centrale** Évaluation / diagnostic · policlinique

Une femme de 44 ans, fatiguée, a des céphalées et une hypotension orthostatique. fT4 basse, TSH 1,2 mU/L (normale).

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Lévothyroxine 50 µg/j immédiatement
- **B** Conclure à un bilan thyroïdien normal
- **C** Répéter la TSH seule dans 3 mois
- **D** Anti-TPO
- **E** Cortisol et IRM hypophysaire

Q63 **SPE · Médecine intensive** **DX.9 · coma myxœdémateux** Prise en charge · urgences

Une femme de 81 ans, hypothyroïdienne non suivie, est retrouvée somnolente en hiver. Température 33,8 °C, FC 46/min, natrémie 126 mmol/L.

Quel est l'ordre thérapeutique correct ?

- **A** Lévothyroxine orale 25 µg/j et retour à domicile le jour même
- **B** Lévothyroxine IV seule, sans corticoïde
- **C** Hydrocortisone IV avant ou avec la lévothyroxine IV
- **D** Réchauffement actif rapide seul
- **E** Restriction hydrique stricte d'abord

Q64 **AP** **DX.9 · biotine** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 39 ans asymptomatique a un bilan thyroïdien discordant avec la clinique. Il prend un complément « cheveux et ongles ».

Quelle hypothèse faut-il évoquer avant de conclure ?

- **A** Hypothyroïdie centrale
- **B** Hypothyroïdie infraclinique à traiter
- **C** Interférence de la biotine avec le dosage
- **D** Thyroïdite auto-immune
- **E** Effet de l'âge sur la TSH

Q65 **EX** **DX.10 vs DX.7 · 8 semaines** Prise en charge · cabinet

Une femme de 32 ans est épuisée depuis 8 semaines, après une COVID-19. Elle décrit un malaise post-effort, un sommeil non réparateur et un brouillard cognitif. Bilan de base normal ; pas de drapeau rouge.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Soupçon de SFC ; revoir à 3 mois
- **B** Poser d'emblée le diagnostic de SFC
- **C** Programme d'exercice progressif forcé
- **D** Rassurer : simple convalescence
- **E** Sérologies étendues pour trouver la cause

Q66 **AP** **DX.10 · définition OMS** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 45 ans a eu une COVID-19 confirmée il y a 4 mois. Fatigue et troubles de concentration depuis 10 semaines, apparus après l'infection, sans autre explication.

Selon l'OMS, ce tableau remplit-il la définition de l'affection post-COVID-19 ?

- **A** Non : il faut 6 mois de symptômes
- **B** Non : il faut une sérologie positive
- **C** Non : la fatigue n'en fait pas partie
- **D** Oui, la définition est remplie
- **E** Oui, dès 4 semaines après l'infection

Q67 **AP** **DX.10 · sérologie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 30 ans est fatiguée depuis 5 semaines. Une sérologie montre des IgG anti-EBV positives (contact ancien). Elle demande si « c'est le virus ».

Quelle interprétation est la plus juste ?

- **A** Elle confirme une fatigue post-infectieuse
- **B** Elle impose un antiviral
- **C** Elle prouve un contact ancien seulement
- **D** Elle confirme un SFC
- **E** Elle impose une sérologie de contrôle mensuelle

Q68 **SPE · Pédiatrie** **DX.10 · enfant** Prise en charge · cabinet

Une adolescente de 14 ans est épuisée depuis 5 semaines après une mononucléose, avec malaise post-effort et absences scolaires.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Attendre 6 mois avant toute évaluation
- **B** Programme sportif scolaire intensif
- **C** Soupçon de SFC ; avis pédiatrique
- **D** Antidépresseur d'emblée
- **E** Rassurer sans suivi

Q69 **EX** **DX.11 · histologie** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 66 ans, fatigué et amaigri, a une masse pulmonaire spiculée au TDM et un CEA élevé. Il demande si « le diagnostic est posé ».

Quel élément pose le diagnostic de cancer ?

- **A** Une biopsie avec histologie
- **B** L'image TDM typique
- **C** Le marqueur tumoral élevé
- **D** La TEP au FDG
- **E** La perte de poids associée

Q70 **EX** **DX.11 🚩 · compression médullaire** Prise en charge · urgences

Un homme de 71 ans avec cancer de la prostate métastatique a une dorsalgie nocturne depuis 2 semaines ; depuis hier, ses jambes sont faibles et il urine mal.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Radiographie lombaire et antalgiques, puis revoir
- **B** IRM programmée dans la semaine
- **C** IRM du rachis entier et dexaméthasone
- **D** Acide zolédronique 4 mg
- **E** Kinésithérapie de renforcement

Q71 **EX** **DX.11 vs DX.10 · lymphome** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 29 ans est fatiguée depuis 2 mois. Fièvre le soir, sueurs nocturnes, perte de 4 kg, adénopathies cervicales indolores de 3 cm. Pas d'infection récente.

Quelle est la démarche la plus appropriée ?

- **A** NFS, LDH, TDM ou TEP, puis biopsie ganglionnaire
- **B** Diagnostic de fatigue post-virale et revoir à 3 mois
- **C** Antibiotique d'épreuve 10 jours
- **D** Ponction à l'aiguille fine seule
- **E** Marqueurs tumoraux sériques

Q72 **SPE · Oncologie** **DX.11 · neutropénie fébrile** Prise en charge · urgences

Une femme de 58 ans sous chimiothérapie pour un cancer du sein est fatiguée et a 38,6 °C. Aucun foyer à l'examen. FC 108/min.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attendre la NFS pour décider
- **B** Hémocultures puis antibiotiques IV
- **C** Antipyrétique et contrôle le lendemain
- **D** Antibiotique oral et retour à domicile
- **E** Rechercher d'abord un foyer par imagerie

Q73 **SPE · Hématologie** **DX.11 · lyse tumorale** Prise en charge · hôpital **question négative**

Un homme de 45 ans avec lymphome à forte charge tumorale va débuter une chimiothérapie. Il a un déficit connu en G6PD.

Quelle mesure est contre-indiquée chez lui ?

- **A** L'hydratation abondante
- **B** La surveillance du potassium et du phosphate
- **C** L'avis néphrologique si la diurèse chute
- **D** L'allopurinol à risque intermédiaire
- **E** La rasburicase

Q74 **AP** **DX.11 · fatigue liée au cancer** Prise en charge · policlinique

Une femme de 55 ans en cours de radiothérapie pour un cancer du sein se plaint d'une fatigue intense. Hb, TSH et glycémie normales ; pas de dépression.

Quelle mesure a le meilleur niveau de preuve contre sa fatigue ?

- **A** Exercice et soutien psychologique
- **B** Méthylphénidate
- **C** Corticoïde au long cours à faible dose
- **D** Repos strict au lit
- **E** Fer IV systématique

🚩 Pièges & alarmes · 14 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

Bilan normal qui rassure à tort, ferritine en inflammation, HbA1c faussée, zolpidem et apnées, exercice gradué, marqueur tumoral, attribution prématurée.

Q75 **EX** **DX.3 · SAOS et zolpidem** Prise en charge · cabinet

Un homme de 49 ans ronfle fort, se réveille fatigué et somnole en réunion. Il demande « un somnifère comme celui de sa femme », du zolpidem.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Zolpidem 10 mg pendant 4 semaines au plus
- **B** Témazépam 10 mg
- **C** Mélatonine Circadin® 2 mg
- **D** Polysomnographie, sans hypnotique
- **E** TCC-I seule sans autre examen

Q76 **EX** **DX.7 · exercice gradué** Prise en charge · cabinet

Une femme de 36 ans a un syndrome de fatigue chronique confirmé. Son employeur suggère un programme de « remise en forme » avec augmentation fixe de l'effort chaque semaine.

Quelle recommandation est la plus appropriée ?

- **A** Exercice gradué à paliers fixes
- **B** Gestion de l'énergie (pacing)
- **C** Salle de sport trois fois par semaine
- **D** TCC à visée curative
- **E** Lightning Process

Q77 **EX** **DX.7 · symptôme nouveau** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 44 ans a un syndrome de fatigue chronique depuis 2 ans. Il signale depuis 1 mois une faiblesse de la jambe droite et une vision floue d'un œil.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attribuer ces signes au syndrome de fatigue chronique
- **B** Renforcer le pacing et revoir dans 1 an
- **C** Examen neurologique et IRM cérébrale
- **D** Physiothérapie de renforcement
- **E** Augmenter l'antalgique

Q78 **EX** **DX.6 · inflammation** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 63 ans hospitalisé pour une polyarthrite active est fatigué. Hb 108 g/L, CRP 64 mg/L, ferritine 180 µg/L, TSAT 12 %.

Quelle conclusion est la plus juste ?

- **A** La ferritine normale exclut un déficit en fer
- **B** Il faut une gastroscopie urgente
- **C** Il s'agit d'une carence en B12
- **D** Un déficit en fer reste possible
- **E** L'anémie est hémolytique

Q79 **AP** **DX.4 · HbA1c et fer** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 44 ans, asymptomatique, a une HbA1c à 6,6 % et une carence en fer marquée (ferritine 6 µg/L). Glycémie à jeun 5,4 mmol/L.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Le diabète est établi par l'HbA1c
- **B** Débuter la metformine
- **C** Prédiabète certain
- **D** HGPO inutile dans ce cas
- **E** Se fier aux glycémies

Q80 **EX** **DX.8 · hypoglycémie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 58 ans, diabétique sous insuline, décrit des « crises d'angoisse » en fin de matinée : sueurs, tremblements, palpitations. Elle saute souvent le petit-déjeuner.

Quel examen faut-il réaliser en premier ?

- **A** GAD-2 et entretien psychiatrique
- **B** Glycémie pendant un épisode
- **C** Holter de 24 h en ambulatoire
- **D** TSH seule
- **E** Essai de sertraline

Q81 **EX** **DX.1 · bilan normal ne clôt pas** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 69 ans a un épisode dépressif depuis 2 mois, de début récent. Il a perdu 7 kg et transpire la nuit. Le bilan de base est normal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Examen complet et bilan somatique ciblé
- **B** Débuter un ISRS et revoir à 2 semaines
- **C** Psychothérapie seule
- **D** Rassurer : le bilan est normal
- **E** Hospitalisation psychiatrique

Q82 **EX** **DX.5 · fatigue récente après 50 ans** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 63 ans consulte pour une fatigue d'installation récente, progressive depuis 5 semaines. Elle a des selles noires depuis 10 jours.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** PHQ-9 et réévaluation à 4 à 6 semaines
- **B** Fer oral et contrôle dans 3 mois
- **C** TSH et glycémie seules
- **D** NFS, ferritine et avis gastro-entérologique
- **E** Polysomnographie

Q83 **EX** **DX.2 · artère normale** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 74 ans a une céphalée temporale nouvelle, une claudication de la mâchoire et une CRP à 55 mg/L. Le pouls temporal est bien perçu et l'artère est souple.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** L'artérite est exclue par l'artère souple
- **B** Il s'agit d'une polymyalgie isolée
- **C** Attendre la biopsie avant tout corticoïde
- **D** L'artère normale n'exclut pas l'artérite
- **E** La CRP élevée suffit à poser le diagnostic

Q84 **EX** **DX.10 · fièvre persistante** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 38 ans est fatigué depuis 5 semaines après une « grippe ». Il garde une fièvre à 38,3 °C le soir et des frissons. Pas de toux.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Rassurer : séquelle virale banale
- **B** Gestion de l'énergie seule
- **C** Soupçonner un SFC à 6 semaines
- **D** Ibuprofène en automédication prolongée
- **E** Bilan infectieux avec hémocultures

Q85 **EX** **DX.11 · marqueur normal** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 61 ans, fatigué, a perdu 8 kg en 3 mois et a du sang dans les selles. Son CEA est normal. Il est soulagé.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Rassurer : le CEA normal exclut un cancer
- **B** Répéter le CEA dans 3 mois
- **C** Fer oral et contrôle
- **D** Coloscopie malgré le marqueur normal
- **E** PHQ-9 d'abord

Q86 **AP** **DX.3 · comportement complexe** Prise en charge · cabinet

Une femme de 61 ans sous hypnotique depuis 3 semaines a été retrouvée par son mari en train de cuisiner la nuit, sans aucun souvenir le matin. Elle souhaite continuer, car « il aide à dormir ».

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Poursuivre à la même dose
- **B** Réduire la dose de moitié
- **C** Ajouter un second hypnotique
- **D** Arrêt immédiat de l'hypnotique
- **E** Remplacer par un antagoniste de l'orexine

Q87 **EX** **DX.6 · femme ménopausée** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 64 ans, ménopausée depuis 12 ans, est fatiguée. Hb 106 g/L, VGM 76 fL, ferritine 9 µg/L. Elle attribue sa fatigue à « des règles abondantes autrefois ».

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Attribuer la carence aux règles passées
- **B** Fer IV d'emblée sans autre bilan
- **C** Rechercher une perte de sang digestive
- **D** Dosage B12 et folates
- **E** Réévaluation à 6 mois

Q88 **AP** **DX.9 · amaigrissement** Prise en charge · cabinet

Une femme de 34 ans euthyroïdienne, IMC 27, demande de la lévothyroxine « pour maigrir et avoir plus d'énergie », comme une amie.

Quelle réponse est la plus appropriée ?

- **A** Prescrire 25 µg/j à l'essai
- **B** Prescrire 100 µg/j avec contrôle de TSH
- **C** Ajouter la liothyronine pour l'énergie
- **D** Refuser la prescription
- **E** Doser les anti-TPO pour décider

⇢ Algorithme condensé · si… alors…

Si…	Alors…
Instabilité, douleur thoracique, syncope ou idées suicidaires	Urgence : signes vitaux, ECG ; ne pas laisser seul, avis psychiatrique
Glycémie capillaire très élevée ou diabète décompensé	DX.4 : urgence, cétones, puis HbA1c
Perte de poids, fièvre, sueurs nocturnes, adénopathie	DX.11, DX.5 : imagerie ciblée et avis spécialisé
Saignement ou pâleur	DX.6 : NFS, ferritine, source du saignement
PHQ-2 ≥ 3	DX.1, DX.8 : PHQ-9, entretien, risque suicidaire
Somnolence, ronflement, sommeil court	DX.3 : Epworth, polygraphie
Douleur diffuse ou articulaire	DX.2 : examen locomoteur, CRP ou VS
TSH élevée	DX.9 : fT4, contrôle à 2–3 mois
Infection récente	DX.10 : cadre post-infectieux, OMS à 3 mois
Malaise post-effort après 3 mois	DX.7 : SFC, centre spécialisé
Bilan normal, fatigue stable	Hygiène du sommeil, TCC, revue à 4–6 semaines

Source : Phase A · Algorithme discriminant et §10 Arbre décisionnel.

✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

Q1 **EX** **DX.5 · bilan sans signe d'appel**

✅ **C** — Bilan de base limité

① **Pourquoi c'est juste** Sans drapeau rouge, on procède par étapes : anamnèse, examen de la tête aux pieds, puis un bilan de base limité (NFS, CRP, glycémie, TSH, ferritine, créatinine, ALAT). La méta-analyse de 26 études montre que le bilan étendu ne se justifie que devant un signe d'appel.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans signe d'appel, l'imagerie large n'est pas indiquée : le cancer concerne 0,6 % des consultants fatigués.
- **B** Ils ne servent pas au dépistage et peuvent être normaux ou élevés sans cancer.
- **D** Elle relève de la deuxième intention, devant ronflement, apnées ou somnolence.
- **E** Examens de deuxième intention, après une hypothèse ou une première anomalie.

③ **Perle** Revoyez la patiente à 4 à 6 semaines ; la moitié des patients fatigués n'a aucun diagnostic explicatif dans l'année.

④ **Source** Phase A §13 Points clés · LOT_004 audité

Q2 **EX** **DX.1 · bilan normal**

✅ **A** — PHQ-2, puis PHQ-9 et entretien clinique

① **Pourquoi c'est juste** Devant une fatigue avec bilan de base normal, on cherche toujours la dépression et le trouble du sommeil avant de multiplier les examens. La dépression touche 18,5 % des consultants fatigués en premier recours (méta-analyse 2016). PHQ-2 ≥ 3 → PHQ-9 et entretien, avec évaluation du risque suicidaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Aucun déficit neurologique ni céphalée inhabituelle ne la justifie.
- **C** Examen de deuxième intention devant une suspicion d'insuffisance surrénalienne (hypotension, hyperpigmentation).
- **D** Sans ronflement ni somnolence, l'apnée du sommeil n'est pas évoquée.
- **E** Le bilan en cascade n'apporte rien ; l'anhédonie oriente déjà vers l'humeur.

③ **Perle** Un deuil récent n'exclut pas un épisode dépressif : il demande du discernement, pas une étiquette « réactionnelle ».

④ **Source** Phase A §10 Arbre décisionnel · LOT_004 audité

Q3 EX DX.1 🚩E1 · idées suicidaires

✅ **C** — Ne pas la laisser seule, avis psychiatrique urgent

① **Pourquoi c'est juste** Idées suicidaires avec plan, moyens ou intention : risque de passage à l'acte imminent (🚩 E1, DX.1). On ne laisse pas la patiente seule, on écarte les moyens dangereux et on appelle le psychiatre de garde dans l'heure ; hospitalisation si nécessaire, au besoin sous placement à des fins d'assistance.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un plan avec moyens = risque imminent : la sécurité passe avant le traitement.
- **B** Mesures utiles plus tard ; elles ne protègent pas aujourd'hui.
- **D** Le drapeau rouge E1 impose une action le jour même.
- **E** Laisser partir une patiente avec plan et moyens est une faute.

③ **Perle** Demander directement les idées suicidaires ne provoque pas le geste. Plan de sécurité écrit avant toute sortie.

④ **Source** Phase B DX.1 §11 · LOT_004 audité

Q4 EX DX.4 🚩E2 · polyurie

✅ **D** — Glycémie capillaire immédiate

① **Pourquoi c'est juste** Polyurie et polydipsie avec fatigue sont un drapeau rouge de diabète décompensé (🚩 E2, DX.4) : glycémie capillaire immédiate. Une glycémie très élevée avec nausées impose cétones et gaz du sang, puis avis en urgence.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elles font partie du bilan de base, mais polyurie et polydipsie imposent d'abord la glycémie.
- **B** Utile pour confirmer plus tard ; elle ne dit rien de la décompensation aiguë.
- **C** Le tableau n'oriente pas vers une anémie.
- **E** La somnolence n'est pas le problème ici.

③ **Perle** Nausées, vomissements, respiration ample : dosez les cétones même si la glycémie n'est que modérée.

④ **Source** Phase A §4 Démarche, drapeaux rouges · LOT_004 audité

Q5 EX DX.11 🚩E5 · perte de poids

✅ **D** — Imagerie ciblée et avis spécialisé rapide

① **Pourquoi c'est juste** Perte de poids, sueurs nocturnes et adénopathie dure sont des drapeaux rouges de néoplasie (🚩 E5, DX.11) : imagerie ciblée et avis spécialisé sous quelques jours, puis biopsie. Un bilan de base normal n'exclut pas un cancer.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le délai convient sans drapeau rouge ; ici, trois drapeaux rouges sont présents.
- **B** Utile en parallèle, mais il ne doit pas retarder la recherche d'une cause grave.
- **C** Une adénopathie dure, fixe et persistante oriente vers un lymphome ou un cancer.
- **E** Ils ne servent pas au diagnostic ; seule la biopsie prouve.

③ **Perle** Chez les 60 ans et plus, la VPP de la perte de poids pour un cancer dépasse 3 % ; sensibilité 2 à 47 %, spécificité 92 à 99 %.

④ **Source** Phase B DX.11 §4 · LOT_004 audité

Q6 EX DX.6 · fer sans anémie

✅ **E** — Fer oral, contrôle à 6 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Chez la femme réglée avec ferritine < 50 µg/L et Hb > 120 g/L, le fer oral réduit la fatigue de 18,9 points de pourcentage de plus que le placebo (Vaucher, CMAJ 2012). Une ferritine < 30 µg/L affirme le déficit en l'absence d'inflammation. Fer oral 50 à 100 mg/j, contrôle à 6 semaines.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une Hb normale n'exclut pas un déficit en fer, qui peut expliquer la fatigue.
- **B** Le fer IV est réservé à l'échec, à l'intolérance ou à l'impossibilité du fer oral.
- **C** Aucune anémie, a fortiori mal tolérée.
- **D** Chez la femme réglée jeune, les règles expliquent la carence ; l'endoscopie vise l'homme ou la femme ménopausée.

③ **Perle** Interrogez les règles abondantes et l'alimentation pauvre en viande : elles épuisent les réserves.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_004 audité

Q7 **EX** **DX.9 · TSH limite chez l'âgé**

✅ **A** — Pas de traitement hormonal

① **Pourquoi c'est juste** TSH de 4,0 à 10,0 mU/L avec fT4 normale = hypothyroïdie infraclinique (DX.9). Chez les 65 ans et plus, TRUST (NEJM 2017) ne montre aucun bénéfice du traitement sur la fatigue ; la TSH augmente naturellement avec l'âge et se lit selon des normes adaptées.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'essai TRUST ne montre aucun bénéfice sur la fatigue après 65 ans dans la forme infraclinique.
- **C** Dose d'entretien inadaptée, sans indication, et dangereuse chez l'âgé.
- **D** Aucun nodule ni goitre ne la justifie.
- **E** La liothyronine ne s'ajoute pas en routine.

③ **Perle** Un TSH légèrement élevé n'explique pas la fatigue : cherchez dépression, sommeil, médicaments.

④ **Source** Phase A §8 Diagnostic positif · LOT_004 audité

Q8 **EX** **DX.7 · 4 symptômes à 3 mois**

✅ **A** — Syndrome de fatigue chronique

① **Pourquoi c'est juste** NICE 2021 : fatigue invalidante aggravée par l'activité, malaise post-effort, sommeil non réparateur et difficultés cognitives, tous présents, fonction nettement réduite, sans autre explication. Suspicion dès 6 semaines chez l'adulte, diagnostic à 3 mois (DX.7). Aucun test ne le confirme.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Ni humeur triste ni anhédonie : critère A (1 ou 2) absent.
- **C** Elle n'explique pas le malaise post-effort retardé.
- **D** Elle exige une douleur diffuse dans au moins 4 régions sur 5, absente ici.
- **E** Aucune inquiétude excessive ni tension rapportée.

③ **Perle** Le malaise post-effort, retardé de 12 à 72 heures et disproportionné, est le symptôme cardinal ; son absence écarte le diagnostic.

④ **Source** Phase A §8 Diagnostic positif · LOT_004 audité

Q9 **EX** DX.3 vs DX.7 · somnolence

✅ **E** — Interdire la conduite et demander une polysomnographie

① **Pourquoi c'est juste** Somnolence diurne, ronflements et apnées témoignées chez un obèse hypertendu évoquent un SAOS (DX.3). La somnolence au volant impose l'arrêt de la conduite jusqu'au bilan ; STOP-Bang ≥ 3 ou apnées témoignées → polysomnographie, pas d'hypnotique ; PPC si IAH confirmé.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le SAOS suspecté contre-indique le zolpidem et le témazépam.
- **B** La somnolence au volant est un drapeau rouge : on n'attend pas.
- **C** La TCC-I traite l'insomnie chronique, non les apnées.
- **D** La somnolence et les apnées témoignées orientent ailleurs.

③ **Perle** Fatigue ≠ somnolence : demandez s'il s'endort en lisant ou au volant (échelle d'Epworth, seuil usuel 10).

④ **Source** Phase B DX.3 §10 · LOT_004 audité

Q10 **EX** DX.10 · convalescence

✅ **E** — Rassurer, gérer l'énergie, revoir

① **Pourquoi c'est juste** Avant 6 semaines, une fatigue après virose correspond le plus souvent à la convalescence : on rassure, on conseille de ne pas dépenser plus d'énergie qu'on en perçoit et on revoit le patient (DX.10). Après 6 semaines avec les 4 symptômes : soupçon de syndrome de fatigue chronique ; confirmation à 3 mois.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le soupçon se pose seulement après 6 semaines chez l'adulte, le diagnostic à 3 mois.
- **B** NICE déconseille l'exercice comme traitement de la fatigue post-infectieuse.
- **C** Une sérologie ne prouve pas la cause de la fatigue ; aucun test ne pose le diagnostic.
- **D** La capacité se juge selon la fonction ; on prévoit un retour adapté.

③ **Perle** Le facteur qui prédit la fatigue prolongée est la sévérité de l'infection aiguë, non les facteurs psychologiques.

④ **Source** Phase B DX.10 §10 · LOT_004 audité

Q11 **EX** **DX.2 · douleur des ceintures**

✅ **B** — CRP et vitesse de sédimentation

① **Pourquoi c'est juste** Douleur bilatérale des épaules, plus de 50 ans, raideur matinale > 45 minutes : polymyalgie rhumatismale à évoquer (DX.2). CRP et VS d'abord, puis avis rhumatologique ; chercher aussi les signes d'artérite à cellules géantes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie ne précède pas le marqueur inflammatoire dans ce tableau.
- **C** Une douleur des ceintures après 50 ans impose d'abord de chercher l'inflammation.
- **D** Sans céphalée temporale ni trouble visuel, l'artérite n'est pas au premier plan.
- **E** Une myopathie se cherche par la CK devant un déficit proximal.

③ **Perle** Les critères EULAR/ACR 2012 classent, ils ne posent pas le diagnostic. Un bilan normal n'exclut pas une polymyalgie débutante.

④ **Source** Phase B DX.2 §13 · LOT_004 audité

Q12 **EX** **DX.8 · palpitations**

✅ **C** — ECG, TSH, glycémie, électrolytes et hémogramme

① **Pourquoi c'est juste** Avant de conclure à une attaque de panique (DX.8), on exclut une arythmie, une thyrotoxicose, une hypoglycémie et un trouble électrolytique : ECG, TSH, glycémie, électrolytes, hémogramme. L'attaque de panique est un diagnostic d'exclusion.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le diagnostic de panique est d'exclusion : ECG et biologie d'abord.
- **B** On n'hospitalise pas en psychiatrie avant d'avoir exclu une urgence somatique.
- **D** Le traitement suit le diagnostic, qui n'est pas encore posé.
- **E** Un ECG immédiat passe avant l'enregistrement ambulatoire.

③ **Perle** Une patiente jeune n'est pas à l'abri d'un trouble du rythme. Tachycardie, tremblement, perte de poids : la TSH tranche.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_004 audité

Q13 EX DX.4 · confirmer

✅ **D** — Confirmer par un second test un autre jour

① **Pourquoi c'est juste** Diabète (DX.4) : HbA1c ≥ 6,5 %, glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L, glycémie à 2 h de HGPO ≥ 11,1 mmol/L, ou glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L avec symptômes. Sans hyperglycémie symptomatique ni crise, un second test anormal un autre jour est requis.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans symptôme d'hyperglycémie, deux tests anormaux sont nécessaires.
- **B** Le tableau (IMC 29, âge) oriente vers un type 2 ; le diagnostic n'est pas encore posé.
- **C** Elle ne sert pas encore au diagnostic.
- **E** Le prédiabète correspond à une HbA1c de 5,7 à 6,4 %.

③ **Perle** La carence en fer élève l'HbA1c ; l'anémie hémolytique la fausse : utilisez alors la glycémie.

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_004 audité

Q14 EX DX.6 vs DX.11 · homme ferriprive

✅ **B** — Rechercher un saignement digestif

① **Pourquoi c'est juste** Une anémie ferriprive chez l'homme ou la femme ménopausée impose de chercher un saignement digestif ; le cancer colorectal est la cause à exclure (DX.6, DX.11). On ne traite pas à l'aveugle, car cela masque le diagnostic.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On ne traite pas à l'aveugle : la cause doit être cherchée.
- **C** Le VGM bas et la ferritine effondrée signent la carence en fer.
- **D** Une seule lignée atteinte avec ferritine basse n'oriente pas vers la moelle.
- **E** Anémie tolérée, au-dessus du seuil restrictif de 70 à 80 g/L.

③ **Perle** Test immunologique des selles positif = coloscopie : il ne pose pas le diagnostic, la biopsie le pose.

④ **Source** Phase B DX.6 §13 · LOT_004 audité

Q15 **EX** **DX.11 🚩 · hypercalcémie maligne**

✅ **C** — Hydratation IV, puis acide zolédronique 4 mg

① **Pourquoi c'est juste** Calcium corrigé > 3,0 mmol/L chez une patiente cancéreuse = hypercalcémie maligne, urgence oncologique (DX.11). Voie veineuse, ECG, hydratation, puis acide zolédronique 4 mg en perfusion unique d'au moins 15 minutes, sur une voie séparée sans calcium.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS impose de contrôler l'état hydrique avant Zometa®.
- **B** Elle vise la compression médullaire, pas l'hypercalcémie.
- **D** Le patient est déshydraté : on hydrate d'abord.
- **E** Le calcium total sous-estime l'hypercalcémie si l'albumine est basse ; le corrigé suffit.

③ **Perle** Confusion + soif + polyurie + constipation chez un cancéreux : calcémie corrigée immédiate.

④ **Source** Phase B DX.11 §11 · LOT_004 audité

Q16 **EX** **DX.9 · TSH élevée isolée**

✅ **E** — Répéter TSH, fT4 et anti-TPO à 2–3 mois

① **Pourquoi c'est juste** TSH 4,0 à 10,0 mU/L avec fT4 normale = hypothyroïdie infraclinique légère (DX.9, ETA 2013) : on répète après 2 à 3 mois avec les anticorps anti-TPO. On traite d'emblée si TSH > 10 mU/L avant 65 à 70 ans, ou en cas de grossesse ou de projet.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une TSH élevée isolée se confirme avant tout traitement ; le BMJ 2019 déconseille fortement de traiter.
- **B** Sans goitre ni nodule, elle n'est pas indiquée.
- **C** Une cause centrale se cherche devant une fT4 basse sans TSH élevée.
- **D** Une TSH légèrement élevée n'explique pas la fatigue.

③ **Perle** Résultat discordant avec la clinique : pensez à une interférence de la biotine.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_004 audité

Q17 EX DX.1 · avant l'antidépresseur

✅ **B** — Avis psychiatrique, pas d'antidépresseur seul

① **Pourquoi c'est juste** L'épisode décrit évoque une hypomanie passée : le diagnostic devient un trouble bipolaire (DX.1, drapeau R3). On recherche systématiquement une manie ou une hypomanie avant tout antidépresseur, et on demande un avis psychiatrique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un antidépresseur seul peut induire un virage maniaque.
- **C** Même risque de virage, quel que soit l'ISRS.
- **D** Non indiquée et source de dépendance.
- **E** PHQ-9 de 16 ou plus = forme plus sévère.

③ **Perle** Trois questions avant l'ISRS : idées suicidaires, manie passée, substances.

④ **Source** Phase B DX.1 §10 · LOT_004 audité

Q18 EX DX.3 · insomnie chronique

✅ **B** — TCC-I, en personne ou en ligne

① **Pourquoi c'est juste** Insomnie chronique (DX.3) : difficulté d'endormissement ou de maintien ≥ 3 nuits/semaine, ≥ 3 mois, avec retentissement diurne et occasion de dormir adéquate. La TCC-I est le traitement de première ligne ; le médicament vient après son échec.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un hypnotique classique ne dépasse pas 4 semaines et vient après la TCC-I.
- **C** L'indication AIPS commence à 55 ans.
- **D** Traitement court seulement, avec risque de dépendance.
- **E** Le guide européen le déconseille.

③ **Perle** La TCC-I améliore les symptômes dépressifs ; son effet sur la fatigue n'est pas établi.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_004 audité

Q19 EX DX.2 🚩 · artérite

✅ **E** — Glucocorticoïde à haute dose sans délai, avis dans les 24 h

① **Pourquoi c'est juste** Céphalée temporale, claudication de la mâchoire et trouble visuel évoquent une artérite à cellules géantes (DX.2, drapeau R1) : glucocorticoïde à haute dose (EULAR : 40 à 60 mg/j d'équivalent prednisone) sans attendre la biopsie, avis rhumatologique et ophtalmologique dans les 24 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On ne retarde pas le traitement : le risque est la cécité.
- **B** Dose de la polymyalgie ; l'artérite demande 40 à 60 mg/j d'équivalent prednisone.
- **C** Ne protège pas la vue.
- **D** Le tableau est typique ; le corticoïde ne doit pas attendre.

③ **Perle** Une artère temporale normale à la palpation n'exclut pas l'artérite : l'imagerie ou la biopsie tranche.

④ **Source** Phase B DX.2 §10 · LOT_004 audité

Q20 EX DX.10 🚩 · rate

✅ **C** — Appeler le 144, avis chirurgical

① **Pourquoi c'est juste** Pendant une mononucléose, la rate est augmentée de volume ; une douleur brutale du flanc gauche évoque une rupture, souvent sans traumatisme (DX.10, drapeau rouge). La conduite (surveillance ou chirurgie) dépend de l'état hémodynamique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La douleur brutale du flanc gauche peut être une rupture de rate, urgence vitale.
- **B** Le délai est inacceptable devant une tachycardie et une PA basse.
- **D** Elle n'apporte rien à l'urgence.
- **E** Le drapeau rouge impose d'exclure une complication.

③ **Perle** Environ 80 % des ruptures surviennent dans les 3 semaines suivant le début ; mortalité 4,8 %.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_004 audité

Q21 EX DX.8 · TAG

✅ **E** — Trouble anxieux généralisé

① **Pourquoi c'est juste** TAG (DX.8, DSM-5-TR) : inquiétude excessive sur plusieurs domaines, difficile à contrôler, plus de jours qu'autrement depuis au moins 6 mois, avec au moins 3 symptômes sur 6 (agitation, fatigabilité, concentration, irritabilité, tension musculaire, sommeil), après exclusion d'une cause somatique ou toxique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il exige des attaques inattendues et récurrentes, absentes ici.
- **B** Humeur et intérêt conservés : critère A (1 ou 2) absent.
- **C** Pas de malaise post-effort décrit.
- **D** Pas de peur du jugement d'autrui ni d'évitement ciblé.

③ **Perle** L'anxiété perturbe le sommeil, ce qui entretient la fatigue. Le GAD-2 dépiste, l'entretien diagnostique.

④ **Source** Phase B DX.8 §8 · LOT_004 audité

Q22 AP DX.4 · mécanisme

✅ **A** — Les cellules manquent de glucose malgré l'hyperglycémie

① **Pourquoi c'est juste** La fatigue est une voie finale commune. Dans le diabète (DX.4), l'hyperglycémie avec carence d'effet de l'insuline prive les cellules de glucose ; s'y ajoutent la diurèse osmotique par glycosurie (polyurie, polydipsie) et la perte de glucose et d'eau.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Mécanisme de l'infection ou du cancer.
- **C** Mécanisme de l'anémie ou de la carence en fer.
- **D** Mécanisme de l'hypothyroïdie.
- **E** Mécanisme de la dépression.

③ **Perle** Une cause corrigée (glycémie, fer, thyroxine) guérit souvent la fatigue ; une cause psychique ou post-effort demande un suivi.

④ **Source** Phase A §3 Physiopathologie · LOT_004 audité

Q23 **AP** **DX.5 · interpréter la fréquence**

✅ **A** — La fréquence est identique chez les patients non fatigués

① **Pourquoi c'est juste** Méta-analyse de Stadje (2016) : maladie somatique grave chez 4,3 % (IC 2,7 à 6,7) des consultants fatigués, mais la fréquence est identique chez les patients sans fatigue ; l'association n'est pas forcément causale (DX.5). D'où le bilan limité et la réévaluation à intervalle court.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Les études avec témoins montrent une prévalence identique.
- **C** Il ne se justifie que devant un signe d'appel.
- **D** La dépression touche 18,5 % des consultants fatigués.
- **E** La plupart des diagnostics se posent plus tard.

③ **Perle** Un pourcentage décrit sa population, pas une probabilité chez le patient devant vous.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_004 audité

Q24 **EX** **DX.5 🚩E3 · surrénale**

✅ **E** — Hydrocortisone IV sans attendre le cortisol

① **Pourquoi c'est juste** Hypotension, sodium bas et potassium haut évoquent une crise surrénalienne (DX.5, 🚩 E3), mortelle sans traitement. Voie veineuse, prélèvement de cortisol, ACTH et ionogramme sans retarder le traitement, hydrocortisone IV (Solu-Cortef®) et NaCl 0,9 % (1000 mL la première heure).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le délai tue : on prélève, puis on traite sans attendre le résultat.
- **B** Examen de deuxième intention chez le patient stable ; ici, la crise se traite d'emblée.
- **C** La patiente est hypovolémique : il faut au contraire du NaCl 0,9 %.
- **D** L'AIPS désigne l'hydrocortisone comme médicament de choix.

③ **Perle** Piège : attribuer le malaise à la dépression. Pigmentation des plis palmaires et chute tensionnelle debout orientent vers l'insuffisance surrénalienne.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_004 audité

Q25 EX DX.1 vs DX.8 · DX.7

✅ **C** — Épisode dépressif caractérisé

① **Pourquoi c'est juste** DSM-5-TR : au moins 5 des 9 symptômes, presque chaque jour depuis au moins 2 semaines, dont l'humeur dépressive ou la perte d'intérêt, avec retentissement fonctionnel (DX.1). Ici : humeur triste, anhédonie, insomnie, fatigue, culpabilité, trouble de concentration.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il exige au moins 6 mois d'inquiétude excessive.
- **B** Il exige un malaise post-effort et au moins 3 mois (NICE).
- **D** L'humeur triste et l'anhédonie dominent ; la durée de 3 mois manque.
- **E** Aucune infection récente.

③ **Perle** Un PHQ-9 positif dépiste ; seul l'entretien pose le diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_004 audité

Q26 EX DX.1 · forme moins sévère

✅ **B** — Thérapie guidée, activité physique et réévaluation à 2 semaines

① **Pourquoi c'est juste** PHQ-9 < 16 = forme moins sévère (NICE 2022) : soutien, activité physique, thérapie guidée ou TCC ; antidépresseur seulement sur choix éclairé. Réévaluation à 2 semaines ; l'effet attendu apparaît en 4 semaines (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** NICE ne propose pas l'antidépresseur en routine dans la forme moins sévère.
- **C** Aucun drapeau rouge.
- **D** Non indiquée ; ne traite pas la dépression.
- **E** Réservée à la dépression psychotique ou à la stupeur, sur décision du psychiatre.

③ **Perle** PHQ-9 ≥ 16 = forme plus sévère : TCC individuelle avec antidépresseur.

④ **Source** Phase B DX.1 §10 · LOT_004 audité

Q27 **AP** **DX.1 · ISRS**

✅ **E** — 50 mg/j ; +50 mg/semaine au plus ; maximum 200 mg

① **Pourquoi c'est juste** Sertraline (Zoloft®) dans la dépression : 50 mg/j en une prise, dose usuelle et initiale ; paliers de 50 mg par semaine au plus ; maximum 200 mg/j ; effet maximal en 2 à 4 semaines (AIPS). Child-Pugh A ou B : dose réduite d'au moins 50 % ; contre-indiquée en Child-Pugh C.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Paliers trop rapides : la demi-vie d'environ 24 h impose au plus une modification par semaine.
- **B** La dose maximale AIPS est 200 mg/j.
- **C** Le traitement se poursuit au moins 6 mois après la rémission, avec arrêt progressif.
- **D** On débute à 50 mg ; l'effet apparaît en 2 à 4 semaines quelle que soit la dose.

③ **Perle** Sertraline + tramadol, triptan ou linézolide : pensez au syndrome sérotoninergique.

④ **Source** Phase A §11.B Pharmacologie · LOT_004 audité

Q28 **SPE · Psychiatrie** **DX.1 · durée et suivi**

✅ **A** — Dans 1 semaine

① **Pourquoi c'est juste** Après un antidépresseur, première réévaluation à 2 semaines, ou à 1 semaine si 18 à 25 ans ou risque suicidaire ; PHQ-9 et risque suicidaire à chaque visite. Poursuite au moins 6 mois après la rémission, arrêt progressif (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Entre 18 et 25 ans ou en cas de risque suicidaire, la première réévaluation se fait à 1 semaine.
- **C** Délai trop long pour un jeune patient à risque.
- **D** Inadapté au début du traitement.
- **E** Le suivi actif est la règle.

③ **Perle** Les moins de 30 ans ont plus de pensées suicidaires au début d'un antidépresseur.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_004 audité

Q29 SPE · Psychogériatrie DX.1 · sujet âgé

✅ **A** — 5 mg au départ, maximum 10 mg ; natrémie au début

① **Pourquoi c'est juste** Chez le sujet âgé, Cipralex® débute à 5 mg, maximum 10 mg ; on surveille la natrémie (femmes âgées à risque d'hyponatrémie) et le risque de fracture. ECG si risque de QT long (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Au-delà de 65 ans : 5 mg au départ, 10 mg au maximum.
- **C** Dose trop élevée pour l'âge.
- **D** L'arrêt est progressif, sur au moins 1 à 2 semaines.
- **E** La surveillance du poids concerne surtout la mirtazapine (Remeron®).

③ **Perle** Confusion, chutes, nausées sous ISRS chez l'âgé : dosez le sodium.

④ **Source** Phase B DX.1 §11 · LOT_004 audité

Q30 EX DX.2 vs DX.1 · fibromyalgie

✅ **D** — Indice de douleur diffuse et score de sévérité

① **Pourquoi c'est juste** Fibromyalgie (ACR 2016, DX.2) : indice de douleur diffuse ≥ 7 avec échelle de sévérité ≥ 5, ou indice 4 à 6 avec échelle ≥ 9 ; douleur dans au moins 4 des 5 régions ; durée ≥ 3 mois. Critères valides pour le diagnostic individuel.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les critères de 2016 ne requièrent plus les points douloureux.
- **B** Un bilan normal oriente ; il ne pose pas le diagnostic.
- **C** Elle oriente vers une maladie inflammatoire, non vers la fibromyalgie.
- **E** Le diagnostic reste valable en présence d'autres maladies.

③ **Perle** Un bilan normal ne suffit pas : cherchez aussi dépression, trouble du sommeil et hypothyroïdie.

④ **Source** Phase B DX.2 §8 · LOT_004 audité

Q31 EX DX.2 · fibromyalgie, traitement

✅ **E** — Exercice aérobie régulier

① **Pourquoi c'est juste** Dans la fibromyalgie, l'éducation est la première étape et l'exercice est la seule recommandation forte de l'EULAR (2017) ; l'effet des médicaments est modeste (DX.2). TCC si l'humeur est touchée, réadaptation multimodale si handicap sévère.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle n'a pas l'indication fibromyalgie dans l'AIPS suisse.
- **B** Il traite la polymyalgie, pas la fibromyalgie.
- **C** L'inactivité entretient la douleur et la fatigue.
- **D** Réservés à la douleur inflammatoire ; risque rénal.

③ **Perle** Lyrica® et la duloxétine ne sont pas indiqués dans la fibromyalgie selon l'AIPS suisse.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_004 audité

Q32 SPE · Rhumatologie DX.2 · doses EULAR

✅ **B** — 15 à 25 mg/j, puis décroissance

① **Pourquoi c'est juste** EULAR 2025 : polymyalgie 15 à 25 mg/j d'équivalent prednisone, puis décroissance prudente ; artérite 40 à 60 mg/j. Surveillance : CRP, douleur, raideur, et au long cours glycémie, tension, poids, densité osseuse (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de l'artérite à cellules géantes.
- **C** Insuffisant au départ ; la décroissance est la règle.
- **D** L'antalgique soulage mais ne traite pas l'inflammation de la polymyalgie.
- **E** Ils ne remplacent pas le glucocorticoïde, auquel la polymyalgie répond vite ; risque rénal.

③ **Perle** Tout trouble visuel sous traitement d'une polymyalgie = urgence (artérite).

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_004 audité

Q33 **AP** **DX.2 · classification**

✅ **D** — Ils classent, sans poser le diagnostic

① **Pourquoi c'est juste** Critères EULAR/ACR 2012 de polymyalgie : âge ≥ 50 ans, douleur bilatérale des épaules, CRP ou VS augmentée ; score ≥ 4 : sensibilité 68 %, spécificité 78 %. Ce sont des critères de classification, non diagnostiques (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le seuil de classification est un score d'au moins 4.
- **B** La biopsie concerne l'artérite.
- **C** L'absence de facteur rhumatoïde et d'ACPA rapporte 2 points.
- **E** Une raideur de plus de 45 minutes rapporte 2 points.

③ **Perle** Raideur > 45 min (2 points), hanche (1), absence de FR et d'ACPA (2), absence de douleur périphérique (1).

④ **Source** Phase B DX.2 §8 · LOT_004 audité

Q34 **EX** **DX.3 · sommeil insuffisant**

✅ **C** — Sommeil insuffisant

① **Pourquoi c'est juste** Sommeil insuffisant (DX.3) : durée courte (< 7 heures chez l'adulte) avec fatigue, amélioration quand le sommeil s'allonge. Conduite : allonger le temps au lit, cible ≥ 7 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'insomnie exige une difficulté à dormir malgré une occasion adéquate.
- **B** Rien n'évoque des apnées, et la récupération le week-end est nette.
- **D** Aucun symptôme thymique.
- **E** Le repos soulage clairement la fatigue.

③ **Perle** Agenda du sommeil de 2 semaines : distinguer insomnie, sommeil insuffisant, apnées, jambes sans repos et décalage circadien.

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_004 audité

Q35 AP DX.3 · hypnotique

✅ **E** — Zolpidem 5 mg, 4 semaines au plus

① **Pourquoi c'est juste** Un hypnotique classique ne dépasse pas 4 semaines, arrêt progressif compris (AIPS) ; zolpidem 10 mg/j au maximum, 5 mg chez le sujet âgé ; témazépam 10 mg chez l'âgé. On réduit progressivement pour éviter le sevrage (DX.3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sujet âgé : 5 mg ; durée maximale 4 semaines.
- **B** Sujet âgé : 10 mg ; traitement court seulement.
- **C** Le guide européen la déconseille.
- **D** Le guide européen le déconseille dans l'insomnie.

③ **Perle** Zolpidem et témazépam sont contre-indiqués en cas d'apnées du sommeil.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_004 audité

Q36 SPE · Médecine du sommeil DX.3 · daridorexant

✅ **B** — 50 mg le soir ; revoir dans 3 mois

① **Pourquoi c'est juste** Daridorexant (Quviviq®) : insomnie chronique de l'adulte (≥ 3 mois, impact diurne) ; 50 mg le soir dans les 30 minutes avant le coucher, 25 mg possible, maximum 50 mg/j ; 25 mg si insuffisance hépatique modérée. Réévaluer dans les 3 mois. Contre-indiqué en cas de narcolepsie et avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (DX.3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Schéma du zolpidem.
- **C** Schéma de la mélatonine Circadin®.
- **D** Une seule prise le soir, maximum 50 mg/j.
- **E** La prise se fait dans les 30 minutes avant le coucher.

③ **Perle** Les antagonistes de l'orexine peuvent aussi provoquer un comportement complexe du sommeil.

④ **Source** Phase B DX.3 §11 · LOT_004 audité

Q37 **AP** **DX.3 · SAOS, sévérité**

✅ **E** — SAOS sévère

① **Pourquoi c'est juste** SAOS (DX.3) : polysomnographie avec IAH ≥ 5 et symptômes ; léger à modéré de 5 à < 30, sévère ≥ 30. Traitement : PPC.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Léger à modéré : IAH de 5 à moins de 30.
- **B** Un IAH ≥ 5 avec symptômes définit le SAOS.
- **C** L'insomnie est un diagnostic clinique.
- **D** IAH ≥ 30 = sévère.

③ **Perle** STOP-Bang ≥ 3 : sensibilité 90 % pour un SAOS en clinique du sommeil ; avec un score de 3, probabilité d'un SAOS sévère de 25 %.

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_004 audité

Q38 **EX** **DX.4 · metformine et rein**

✅ **A** — Elle est contre-indiquée à ce DFGe

① **Pourquoi c'est juste** Metformine (Glucophage®) : contre-indiquée si DFGe < 30 mL/min/1,73 m², acidose métabolique, déshydratation, infection grave, produit de contraste iodé IV. DFGe 30 à 59 : 500 ou 850 mg au départ, maximum 1000 mg/j (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le DFGe < 30 la contre-indique.
- **C** Ce plafond vaut pour un DFGe de 30 à 59.
- **D** Le contrôle trimestriel vaut pour 30 à 44 ; sous 30, on l'arrête.
- **E** La metformine est le traitement du type 2.

③ **Perle** Arrêt 48 h avant un produit de contraste iodé si le DFGe est < 60.

④ **Source** Phase A §11.B Pharmacologie · LOT_004 audité

Q39 EX DX.4 · HbA1c faussée

✅ **D** — La glycémie veineuse

① **Pourquoi c'est juste** L'HbA1c n'est pas fiable en cas d'anémie hémolytique, d'hémoglobinopathie, d'insuffisance rénale sévère ou de grossesse : on utilise la glycémie (DX.4). Avec des symptômes, une glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L suffit.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle restera faussée par l'hémolyse.
- **B** Une glycémie capillaire ne suffit pas au diagnostic.
- **C** Elle ne sert pas encore au diagnostic.
- **E** Il n'est utile que chez les patients sous insuline.

③ **Perle** La carence en fer, elle, élève l'HbA1c.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_004 audité

Q40 SPE · Endocrinologie DX.4 · SGLT2

✅ **D** — Acidocétose euglycémique

① **Pourquoi c'est juste** Sous inhibiteur du SGLT2, l'acidocétose peut survenir avec une glycémie modérée, parfois < 14 mmol/L : on dose les cétones (β-OHB), le gaz du sang, et on arrête l'empagliflozine (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Vomissements et respiration ample imposent les cétones.
- **B** La glycémie est trop basse pour ce diagnostic.
- **C** La glycémie est à 12 mmol/L.
- **E** La glycémie modérée ne rassure pas sous inhibiteur du SGLT2.

③ **Perle** Résolution de l'acidocétose : cétones < 0,6 mmol/L et pH ≥ 7,3 (ou bicarbonate ≥ 18 mmol/L).

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_004 audité

Q41 **SPE · Médecine intensive** DX.4 · acidocétose, potassium

✅ **E** — Retarder l'insuline et donner du potassium

① **Pourquoi c'est juste** Acidocétose : remplissage par NaCl 0,9 %, puis insuline IV avec potassium. L'insuline n'est retardée que si K+ < 3,5 mmol/L, jusqu'à ce qu'il remonte ; sinon on ajoute le potassium dès que K+ < 5,0 mmol/L (consensus 2024, DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'insuline fait baisser la kaliémie : sous 3,5 mmol/L, on la retarde.
- **B** Pas de bicarbonate en routine.
- **C** L'acidocétose exige une hospitalisation.
- **D** Le glucose s'ajoute quand la glycémie passe sous 13,9 mmol/L.

③ **Perle** Quand la glycémie passe sous 13,9 mmol/L : glucose 5 à 10 % et insuline réduite à 0,05 UI/kg/h.

④ **Source** Phase B DX.4 §13 · LOT_004 audité

Q42 **AP** DX.4 · hypoglycémie

✅ **B** — Glucagon 1 mg SC ou IM

① **Pourquoi c'est juste** Hypoglycémie sévère inconsciente (DX.4) : glucagon 1 mg SC ou IM ; sans réponse en 10 minutes, glucose 40 % IV ; dès le réveil, hydrates de carbone par voie orale pour reconstituer le glycogène et éviter la rechute.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué chez un patient inconscient (risque de fausse route).
- **C** L'hypoglycémie sévère se corrige vite et doit être traitée immédiatement.
- **D** Elle aggrave l'hypoglycémie.
- **E** Sans effet sur l'hypoglycémie aiguë.

③ **Perle** Prévenez le patient du risque d'hypoglycémie au volant sous insuline ou sulfamide.

④ **Source** Phase B DX.4 §13 · LOT_004 audité

Q43 **EX** **DX.5 · insuffisance cardiaque**

✅ **B** — NT-proBNP et échocardiographie

① **Pourquoi c'est juste** Orthopnée, œdèmes, crépitants et galop orientent vers une insuffisance cardiaque (DX.5) : NT-proBNP et échocardiographie. On cherche un signe d'organe ciblé, puis le bilan de l'organe.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un examen d'organe ciblé passe avant le bilan de base devant ces signes cardiaques.
- **C** Les signes d'organe orientent vers une cause somatique, pas thymique.
- **D** Elles n'expliquent ni les œdèmes ni les crépitants.
- **E** L'orthopnée n'est pas une apnée du sommeil.

③ **Perle** Chez la personne âgée, la fatigue seule peut être la seule plainte d'une insuffisance cardiaque.

④ **Source** Phase B DX.5 §4 · LOT_004 audité

Q44 **EX** **DX.5 · endocardite**

✅ **C** — Hémocultures, puis échocardiographie

① **Pourquoi c'est juste** Une fièvre avec souffle nouveau impose des hémocultures puis une échocardiographie (DX.5). Piège : ne pas penser à l'endocardite sans fièvre franche.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les hémocultures doivent précéder tout antibiotique.
- **B** Fièvre et souffle nouveau sont des drapeaux rouges.
- **D** Elles ne répondent pas à la question de l'endocardite.
- **E** La cause somatique est au premier plan.

③ **Perle** Fièvre prolongée ou sueurs nocturnes : infection chronique (tuberculose, endocardite, VIH) ou lymphome.

④ **Source** Phase B DX.5 §10 · LOT_004 audité

Q45 **AP** **DX.5 · résultat isolé**

✅ **A** — Répéter et corréler à la clinique

① **Pourquoi c'est juste** Un résultat discordant ou limite a une valeur peu spécifique : on le répète, on le corrèle à la clinique et on évite le bilan en cascade (DX.5). Réévaluer à intervalle court.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un résultat isolé légèrement anormal ne suffit pas à expliquer la fatigue.
- **C** Elle relève d'un signe d'appel (perte de poids, adénopathie).
- **D** Aucune cytopénie ni signe hématologique.
- **E** Aucun foyer infectieux.

③ **Perle** Une maladie grave peut coexister avec une dépression, fréquente.

④ **Source** Phase B DX.5 §8 · LOT_004 audité

Q46 **SPE · Endocrinologie** **DX.5 · relais oral**

✅ **D** — Hydrocortisone orale 10 à 20 mg/j

① **Pourquoi c'est juste** Relais oral de la substitution (AIPS Hydrocortison Galepharm) : insuffisance surrénale chronique 10 à 20 mg/j, parfois davantage, avec 4 à 6 g de chlorure de sodium ou un minéralocorticoïde (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS désigne l'hydrocortisone ou la cortisone comme médicaments de choix.
- **B** Dose de crise, pas de substitution.
- **C** L'insuffisance surrénale chronique demande une substitution.
- **E** Le traitement parentéral à hautes doses se limite en général à 48–72 heures (AIPS).

③ **Perle** Une corticothérapie prolongée supprime la surrénale : l'arrêt est progressif.

④ **Source** Phase B DX.5 §11 · LOT_004 audité

Q47 EX DX.6 · macrocytaire

✅ **C** — Doser B12, folates et MMA

① **Pourquoi c'est juste** Anémie macrocytaire avec troubles neurologiques : carence en B12 à évoquer (DX.6). On dose B12, folates et MMA ; on exclut une carence en B12 avant l'acide folique, car l'atteinte neurologique peut devenir irréversible.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il laisse progresser l'atteinte neurologique d'une carence en B12.
- **B** Le VGM haut n'oriente pas vers une carence en fer.
- **D** Anémie tolérée.
- **E** Réservé à l'anémie rénale ou chimio-induite.

③ **Perle** Un VGM normal n'exclut pas une carence mixte : fer et B12 s'annulent.

④ **Source** Phase B DX.6 §10 · LOT_004 audité

Q48 SPE · Hématologie DX.6 · hémolyse

✅ **C** — LDH, haptoglobine, frottis

① **Pourquoi c'est juste** Ictère avec urines foncées = drapeau rouge d'hémolyse (DX.6). VGM normal et réticulocytes hauts : chercher d'abord un saignement, puis une hémolyse (LDH, haptoglobine, frottis).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le tableau n'est pas celui d'une carence en fer.
- **B** Aucun saignement ; ictère et réticulocytes orientent vers l'hémolyse.
- **D** Le VGM est normal.
- **E** Les réticulocytes hauts montrent une moelle qui produit.

③ **Perle** Piège : donner du fer à une anémie non ferriprive.

④ **Source** Phase B DX.6 §4 · LOT_004 audité

Q49 AP DX.6 · Ferinject®

✅ **B** — Il est contre-indiqué au 1er trimestre

① **Pourquoi c'est juste** Ferinject® : contre-indiqué au 1er trimestre ; au 2e et 3e trimestre, seulement en indication stricte. Dose unique au plus 15 mg/kg en injection ou 20 mg/kg en perfusion, sans dépasser 1000 mg ; maximum 1000 mg par semaine ; Hb au plus tôt 4 semaines après (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS le contre-indique au 1er trimestre.
- **C** Au plus 1000 mg de fer par semaine.
- **D** L'association est déconseillée (AIPS).
- **E** Surveillance de 30 minutes après la dose.

③ **Perle** Doses répétées de Ferinject® avec facteurs de risque : surveiller le phosphate (hypophosphatémie).

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_004 audité

Q50 AP DX.6 · transfusion

✅ **A** — Seuil restrictif de 70 à 80 g/L

① **Pourquoi c'est juste** Choosing Wisely : seuil restrictif d'Hb de 70 à 80 g/L chez le patient hospitalisé stable ; on adapte chez le cardiaque ou l'instable (DX.6). Prélever NFS, groupe, coagulation, ferritine, B12 et folates avant toute transfusion.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le seuil OMS définit l'anémie, pas l'indication transfusionnelle.
- **C** Trop bas chez un patient hospitalisé.
- **D** Aucune justification.
- **E** Le fer agit en semaines ; ce n'est pas la question du seuil.

③ **Perle** La transfusion se réserve aux anémies mal tolérées.

④ **Source** Phase B DX.6 §11 · LOT_004 audité

Q51 EX DX.7 vs DX.1 · PEM

✅ **A** — Épisode dépressif caractérisé

① **Pourquoi c'est juste** Le malaise post-effort est le symptôme cardinal du syndrome de fatigue chronique ; son absence l'écarte (DX.7). Anhédonie et dévalorisation orientent vers la dépression (DX.1). Les deux peuvent coexister.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'absence de malaise post-effort écarte le diagnostic.
- **C** Aucune infection récente.
- **D** Aucune douleur diffuse.
- **E** Le bilan de base, TSH comprise, est normal.

③ **Perle** PEM absent → chercher dépression, apnée, carence, endocrinopathie.

④ **Source** Phase B DX.7 §10 · LOT_004 audité

Q52 AP DX.7 · référentiels

✅ **B** — 6 mois

① **Pourquoi c'est juste** Trois référentiels : IOM 2015 (> 6 mois, 3 symptômes obligatoires + 1), NICE 2021 (suspicion 6 semaines, diagnostic 3 mois), critères canadiens (5 critères majeurs + 2 mineurs sur 3 ; 6 mois chez l'adulte, 3 mois chez l'enfant), recommandés par le consensus D-A-CH (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** C'est le seuil de suspicion de NICE chez l'adulte.
- **C** C'est la durée de diagnostic de NICE, et celle des critères canadiens chez l'enfant.
- **D** Durée de l'épisode dépressif (DSM-5-TR).
- **E** Aucun référentiel ne l'exige.

③ **Perle** Le D-A-CH juge les critères de l'IOM suffisants pour le soupçon, non pour la suite.

④ **Source** Phase B DX.7 §8 · LOT_004 audité

Q53 **SPE · Médecine interne** DX.7 · orthostatisme

✅ **A** — Tachycardie orthostatique posturale (POTS)

① **Pourquoi c'est juste** Test debout de 10 minutes : POTS si la FC monte d'au moins 30/min (40 avant 20 ans). L'intolérance orthostatique renforce le diagnostic de syndrome de fatigue chronique (DX.7). Mesures : hydratation, sel, bas de contention, éviter la station debout prolongée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Une hausse d'au moins 30/min chez l'adulte est pathologique.
- **C** La pression ne chute pas.
- **D** Elle se teste par le cortisol à 9 h.
- **E** Syncope ou douleur thoracique imposeraient d'abord un ECG ; ici la réponse est posturale.

③ **Perle** Les médicaments de l'orthostatisme sévère sont hors indication et réservés à un expert.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_004 audité

Q54 **AP** DX.7 · pharmacologie

✅ **C** — Commencer à faible dose et augmenter lentement

① **Pourquoi c'est juste** Aucun médicament ne guérit le syndrome de fatigue chronique ; on traite les symptômes. Le consensus D-A-CH cite des doses de départ de 1/10 à 1/4 de la dose usuelle chez les patients sensibles (DX.7). Paracétamol en première ligne pour la douleur.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ces patients tolèrent mal : on commence bas.
- **B** Aucun médicament ne guérit le syndrome.
- **D** À éviter sans indication.
- **E** Non recommandé ; il ne guérit pas.

③ **Perle** Métamizole : agranulocytose possible, indépendante de la dose ; arrêt si fièvre, angine ou aphtes.

④ **Source** Phase B DX.7 §11 · LOT_004 audité

Q55 EX DX.8 · trouble panique

✅ **B** — Trouble panique

① **Pourquoi c'est juste** Trouble panique (DX.8, DSM-5-TR) : attaques inattendues et récurrentes avec au moins 4 symptômes, suivies d'au moins 1 mois d'inquiétude persistante ou de changement de comportement, après exclusion d'une cause somatique ou toxique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il exige une inquiétude diffuse depuis au moins 6 mois.
- **C** Les attaques sont récurrentes, avec inquiétude persistante.
- **D** Les attaques sont inattendues, non liées à un objet précis.
- **E** Aucun symptôme thymique décrit.

③ **Perle** Une attaque de panique isolée ne suffit pas.

④ **Source** Phase B DX.8 §10 · LOT_004 audité

Q56 EX DX.8 · TAG, première ligne

✅ **B** — TCC ou ISRS/IRSN

① **Pourquoi c'est juste** TAG (DX.8) : TCC (12 à 15 séances hebdomadaires d'une heure) en première intention, ou ISRS/IRSN selon la préférence ; les benzodiazépines ne sont pas recommandées. Le traitement efficace se poursuit au moins un an.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les benzodiazépines ne sont pas recommandées dans le TAG.
- **C** À éviter en soins primaires.
- **D** Pas de première ligne.
- **E** Retentissement marqué : échelon 3 (TCC ou médicament).

③ **Perle** La psychothérapie par psychologue-psychothérapeute sur prescription médicale est remboursée par l'AOS depuis juillet 2022.

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_004 audité

Q57 **SPE · Psychiatrie** **DX.8 · prégabaline**

✅ **A** — 150 mg/j, jusqu'à 600 mg

① **Pourquoi c'est juste** Prégabaline (Lyrica®) dans le TAG : 150 mg/j, jusqu'à 600 mg ; réservée si ISRS et IRSN ne sont pas tolérés ; arrêt progressif sur plusieurs semaines ; risque d'abus. Dose réduite si clairance < 60 mL/min (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Schéma de l'escitalopram.
- **C** Schéma de la venlafaxine.
- **D** Schéma de l'hydroxyzine.
- **E** Schéma du lorazépam.

③ **Perle** Clairance 30 à 60 : 75 mg/j au départ, 300 mg au plus.

④ **Source** Phase B DX.8 §11 · LOT_004 audité

Q58 **SPE · Psychiatrie** **DX.8 · grossesse**

✅ **D** — Atarax® est contre-indiqué pendant la grossesse

① **Pourquoi c'est juste** AIPS : Atarax® contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement ; Deroxat® à ne pas débuter chez la femme enceinte ou qui envisage une grossesse (malformation cardiovasculaire environ 1/50 contre 1/100) ; Temesta® à éviter (malformations au 1er trimestre) (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ne pas le débuter : malformations cardiovasculaires au 1er trimestre.
- **B** Il est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.
- **C** Risque de malformations au 1er trimestre.
- **E** HPPN : 6 à 12 cas pour 1000, contre 1 à 2.

③ **Perle** Chez l'enfant, la TCC est le premier choix.

④ **Source** Phase B DX.8 §11 · LOT_004 audité

Q59 EX DX.9 · forme manifeste

✅ **B** — Lévothyroxine 25 à 50 µg/j, TSH à 2 mois

① **Pourquoi c'est juste** Hypothyroïdie primaire manifeste (DX.9) : TSH élevée et fT4 basse. Lévothyroxine (Euthyrox®) 25 à 50 µg/j le matin à jeun, au moins une demi-heure avant le petit-déjeuner, paliers de 25 à 50 µg toutes les 2 à 4 semaines ; entretien 100 à 200 µg/j ; TSH à 2 mois. Cible TSH 0,4 à 2,5 mU/L.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une TSH élevée avec fT4 basse définit la forme manifeste : traitement indiqué.
- **C** On débute bas et on augmente par paliers de 25 à 50 µg toutes les 2 à 4 semaines.
- **D** La lévothyroxine seule reste la référence.
- **E** La TSH élevée signe une origine primaire.

③ **Perle** Âgé ou cardiaque : débuter à 25 µg, ECG avant.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_004 audité

Q60 EX DX.9 · TSH > 10

✅ **B** — Traiter par lévothyroxine

① **Pourquoi c'est juste** Hypothyroïdie infraclinique marquée (TSH > 10 mU/L, fT4 normale) : l'ETA 2013 recommande de traiter avant 65 à 70 ans, même sans symptôme (DX.9). Après 80 à 85 ans, une TSH ≤ 10 se surveille.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Avant 65 à 70 ans, une TSH > 10 mU/L se traite même sans symptôme (ETA 2013).
- **C** C'est le seuil du BMJ 2019, plus restrictif.
- **D** Pas en routine.
- **E** La confirmation est faite ; la décision est due.

③ **Perle** Les anticorps anti-TPO signent l'auto-immunité, non le déficit.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_004 audité

Q61 AP DX.9 · interactions

✅ **E** — Prendre la lévothyroxine au moins 2 h avant fer et calcium

① **Pourquoi c'est juste** La lévothyroxine se prend le matin à jeun, au moins une demi-heure avant le petit-déjeuner et au moins 2 heures avant les sels de fer, de calcium et d'aluminium ; 4 à 5 heures avant les résines. IPP, soja et orlistat réduisent aussi l'absorption (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un repas réduit l'absorption jusqu'à 20 %.
- **B** On corrige d'abord l'interaction.
- **C** Il suffit de décaler les prises.
- **D** Fer et calcium réduisent l'absorption.

③ **Perle** Demi-vie d'environ 7 jours : l'équilibre exige plusieurs semaines, d'où la TSH à 2 mois.

④ **Source** Phase B DX.9 §11 · LOT_004 audité

Q62 SPE · Endocrinologie DX.9 · hypothyroïdie centrale

✅ **E** — Cortisol et IRM hypophysaire

① **Pourquoi c'est juste** Hypothyroïdie centrale (DX.9) : fT4 basse avec TSH basse ou normale. On cherche une cause hypophysaire (cortisol, IRM, avis endocrinologique) avant la lévothyroxine ; l'AIPS impose de traiter la surrénale d'abord.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Seule, elle peut déclencher une crise surrénalienne : traiter la surrénale d'abord.
- **B** Une fT4 basse sans TSH élevée signe une atteinte hypophysaire.
- **C** Doser seulement la TSH fait manquer la forme centrale.
- **D** Ils signent une auto-immunité thyroïdienne, sans lien avec la forme centrale.

③ **Perle** Une TSH normale n'exclut pas une dysfonction hypophysaire.

④ **Source** Phase B DX.9 §10 · LOT_004 audité

Q63 **SPE · Médecine intensive** **DX.9 · coma myxœdémateux**

✅ **C** — Hydrocortisone IV avant ou avec la lévothyroxine IV

① **Pourquoi c'est juste** Coma myxœdémateux (DX.9) : soins intensifs ; prélever TSH, fT4, cortisol ; réchauffer passivement ; hydrocortisone (Solu-Cortef®, jusqu'à 100 mg IV) avant ou avec la lévothyroxine IV ; chercher et traiter le facteur déclenchant (froid, infection, sédatif).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Urgence vitale de soins intensifs.
- **B** Un déficit surrénalien associé se démasque quand le métabolisme accélère.
- **D** On réchauffe passivement ; le traitement hormonal est indispensable.
- **E** Elle ne traite pas la cause.

③ **Perle** Piège : attribuer la somnolence à l'âge ou à la dépression.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_004 audité

Q64 **AP** **DX.9 · biotine**

✅ **C** — Interférence de la biotine avec le dosage

① **Pourquoi c'est juste** Un résultat thyroïdien discordant avec la clinique doit faire penser à une interférence de la biotine avant de conclure (DX.9). Le patient signale la biotine au laboratoire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Rien ne l'évoque cliniquement.
- **B** On ne traite pas un résultat discordant avant d'avoir exclu une interférence.
- **D** Elle ne donne pas de dosage discordant isolé.
- **E** Le patient a 39 ans.

③ **Perle** Symptômes seuls ou anti-TPO seuls ne suffisent pas : la biologie tranche.

④ **Source** Phase B DX.9 §8 · LOT_004 audité

Q65 **EX** **DX.10 vs DX.7 · 8 semaines**

✅ **A** — Soupçon de SFC ; revoir à 3 mois

① **Pourquoi c'est juste** Après une infection, 4 symptômes NICE persistant ≥ 6 semaines chez l'adulte avec activité nettement réduite = soupçon de syndrome de fatigue chronique : gestion de l'énergie, pas d'exercice forcé, réévaluation à 3 mois (DX.10, DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le diagnostic se confirme à 3 mois.
- **C** NICE le déconseille, surtout avec malaise post-effort.
- **D** Après 6 semaines avec les 4 symptômes, on pose le soupçon.
- **E** Aucun test ne pose le diagnostic.

③ **Perle** Environ la moitié des patients post-COVID avec PEM remplit les critères de SFC.

④ **Source** Phase B DX.10 §10 · LOT_004 audité

Q66 **AP** **DX.10 · définition OMS**

✅ **D** — Oui, la définition est remplie

① **Pourquoi c'est juste** OMS 2022 : infection par le SARS-CoV-2 probable ou confirmée, symptômes habituellement à 3 mois du début, durant au moins 2 mois, non expliqués par un autre diagnostic (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** C'est le délai de l'IOM pour le SFC.
- **B** L'infection probable ou confirmée suffit.
- **C** La fatigue en est un symptôme fréquent.
- **E** Le cadre OMS se pose à 3 mois.

③ **Perle** Une cohorte suisse : arrêts de travail ≥ 1 mois chez 11,5 % des personnes avec séquelles de COVID-19, contre 4,0 %.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_004 audité

Q67 AP DX.10 · sérologie

✅ **C** — Elle prouve un contact ancien seulement

① **Pourquoi c'est juste** Une sérologie EBV ancienne positive prouve un contact ancien, non la cause de la fatigue actuelle (DX.10). Le diagnostic est clinique et d'exclusion ; le bilan de base sert à exclure une autre cause.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une sérologie ancienne ne prouve pas la cause.
- **B** Aucun traitement ne guérit cette fatigue.
- **D** Aucun test ne confirme le SFC.
- **E** Aucune utilité.

③ **Perle** Après mononucléose, 13 %, 7 % et 4 % des adolescents ont encore un SFC à 6, 12 et 24 mois.

④ **Source** Phase B DX.10 §8 · LOT_004 audité

Q68 SPE · Pédiatrie DX.10 · enfant

✅ **C** — Soupçon de SFC ; avis pédiatrique

① **Pourquoi c'est juste** Chez l'enfant, NICE pose le soupçon de SFC après 4 semaines (6 chez l'adulte) et le confirme à 3 mois ; évaluation par un pédiatre dès 4 semaines ; revue tous les 6 mois (DX.10, DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Chez l'enfant, le soupçon se pose dès 4 semaines.
- **B** L'exercice forcé est déconseillé.
- **D** Aucune dépression décrite.
- **E** Le suivi est nécessaire ; revue tous les 6 mois.

③ **Perle** Les enfants et adolescents ont de meilleures chances de récupération.

④ **Source** Phase B DX.10 §11 · LOT_004 audité

Q69 EX DX.11 · histologie

✅ **A** — Une biopsie avec histologie

① **Pourquoi c'est juste** Le diagnostic de néoplasie maligne repose sur l'histologie : biopsie examinée par le pathologiste, avec immunohistochimie, qui définit type, grade et cible thérapeutique (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'image oriente et stadifie ; seule la biopsie prouve.
- **C** Il peut être élevé sans cancer ; il sert au suivi.
- **D** Elle stadifie, elle ne prouve pas.
- **E** Elle oriente, elle ne prouve pas.

③ **Perle** Un test immunologique des selles positif impose une coloscopie, qui prélève la lésion.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_004 audité

Q70 EX DX.11 🚩 · compression médullaire

✅ **C** — IRM du rachis entier et dexaméthasone

① **Pourquoi c'est juste** Dorsalgie avec faiblesse des jambes ou rétention urinaire chez un cancéreux = compression médullaire (DX.11, E2) : IRM totale du rachis en urgence, corticoïde dès la suspicion, avis de radio-oncologie et de neurochirurgie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle ne montre pas la compression ; l'urgence est l'IRM.
- **B** Le déficit devient irréversible sans traitement rapide.
- **D** Il traite l'hypercalcémie maligne.
- **E** Le déficit est neurologique.

③ **Perle** La dorsalgie isolée précède le déficit : elle impose déjà l'IRM chez un patient cancéreux.

④ **Source** Phase B DX.11 §10 · LOT_004 audité

Q71 EX DX.11 vs DX.10 · lymphome

✅ **A** — NFS, LDH, TDM ou TEP, puis biopsie ganglionnaire

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre, sueurs nocturnes et adénopathies indolores évoquent un lymphome (DX.11) : NFS, LDH, imagerie (TDM ou TEP), puis biopsie ganglionnaire, avec échantillon frais en microbiologie et en histologie (un lymphome et une tuberculose donnent le même tableau).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le trio fièvre, sueurs, adénopathies ne s'explique pas par une virose bénigne.
- **C** Ne remplace pas l'exploration.
- **D** La biopsie ganglionnaire envoie un échantillon frais en histologie et en microbiologie.
- **E** Ils ne servent pas au diagnostic.

③ **Perle** Les symptômes B ne qualifient plus le stade que dans le lymphome de Hodgkin (Lugano 2014).

④ **Source** Phase B DX.11 §10 · LOT_004 audité

Q72 SPE · Oncologie DX.11 · neutropénie fébrile

✅ **B** — Hémocultures puis antibiotiques IV

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre sous chimiothérapie = neutropénie fébrile jusqu'à preuve du contraire (DX.11, E4) : constantes, voie veineuse, hémocultures, NFS, CRP, lactate, créatinine, puis antibiothérapie IV à large spectre sans délai selon le protocole local ; hospitalisation, isolement, oncologue.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les antibiotiques ne doivent pas attendre les résultats.
- **C** La neutropénie fébrile tue en quelques heures.
- **D** Hospitalisation et voie IV.
- **E** Un neutropénique peut n'avoir aucun signe localisé.

③ **Perle** Œdème du visage, dyspnée et veines du cou dilatées : obstruction de la veine cave supérieure.

④ **Source** Phase B DX.11 §11 · LOT_004 audité

Q73 SPE · Hématologie DX.11 · lyse tumorale

✅ **E** — La rasburicase

① **Pourquoi c'est juste** Prévention de la lyse tumorale (DX.11) : repérer le risque, perfuser abondamment, pas d'alcalinisation, rasburicase avant la chimiothérapie (0,20 mg/kg/j en 30 minutes, jusqu'à 7 jours), surveillance de K+, phosphate, calcium, acide urique et créatinine. La rasburicase est contre-indiquée en cas de déficit en G6PD.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mesure de base de la prévention.
- **B** Surveillance indispensable pendant les premiers jours.
- **C** Conduite recommandée.
- **D** Utilisé pour prévenir la néphropathie urique.

③ **Perle** Allopurinol : toute éruption impose l'arrêt immédiat.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_004 audité

Q74 AP DX.11 · fatigue liée au cancer

✅ **A** — Exercice et soutien psychologique

① **Pourquoi c'est juste** La fatigue liée au cancer touche jusqu'à 52 % des patients. Exercice, interventions psychologiques et leur association l'améliorent pendant et après le traitement, mieux que les médicaments ; on corrige d'abord les facteurs réversibles (anémie, hypothyroïdie, dépression, insomnie, douleur) (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il n'améliore pas plus la fatigue que le placebo.
- **C** Preuve de très faible certitude.
- **D** Il aggrave le déconditionnement et la fonction.
- **E** Sans carence prouvée, aucune indication.

③ **Perle** Méta-analyse en réseau 2025 : bénéfice de l'exercice de résistance et du yoga.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_004 audité

Q75 EX DX.3 · SAOS et zolpidem

✅ **D** — Polysomnographie, sans hypnotique

① **Pourquoi c'est juste** Ronflement, réveil non reposé et somnolence évoquent un SAOS (DX.3) : zolpidem et témazépam sont contre-indiqués ; on demande une polysomnographie, puis PPC si le SAOS est confirmé.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le SAOS suspecté est une contre-indication.
- **B** Également contre-indiqué en cas d'apnées.
- **C** Indication AIPS dès 55 ans, et elle ne traite pas un SAOS.
- **E** Il faut d'abord exclure les apnées.

③ **Perle** Prescrire un hypnotique avant d'exclure un SAOS est le piège classique.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_004 audité

Q76 EX DX.7 · exercice gradué

✅ **B** — Gestion de l'énergie (pacing)

① **Pourquoi c'est juste** Dans le syndrome de fatigue chronique (DX.7), le pacing est le pilier : rester sous sa limite, alterner activité et repos, fractionner les tâches. NICE ne recommande pas l'exercice gradué à augmentation fixe ; le déconditionnement n'est pas retenu comme cause.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** NICE le déconseille : il peut aggraver l'état.
- **C** À éviter ; l'activité physique est individuelle et supervisée, si la patiente le souhaite.
- **D** La TCC aide à gérer les symptômes, jamais curative.
- **E** Déconseillé par NICE.

③ **Perle** Crash : réduire l'activité sous la limite et ne reprendre qu'après stabilisation.

④ **Source** Phase B DX.7 §13 · LOT_004 audité

Q77 **EX** **DX.7 · symptôme nouveau**

✅ **C** — Examen neurologique et IRM cérébrale

① **Pourquoi c'est juste** Déficit neurologique focal ou trouble visuel : drapeau rouge (DX.7) ; ils évoquent une sclérose en plaques, une tumeur ou une cause vasculaire. Examen neurologique, IRM, avis neurologique. Un symptôme nouveau déclenche une enquête, jamais une attribution automatique au SFC.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un nouveau signe n'est jamais attribué d'emblée au SFC.
- **B** La revue annuelle ne vaut pas pour un symptôme nouveau.
- **D** Un déficit focal impose une imagerie.
- **E** Ne répond pas à la question diagnostique.

③ **Perle** La fatigue de la sclérose en plaques ressemble à celle du SFC, mais sans PEM marqué.

④ **Source** Phase B DX.7 §4 · LOT_004 audité

Q78 **EX** **DX.6 · inflammation**

✅ **D** — Un déficit en fer reste possible

① **Pourquoi c'est juste** L'inflammation augmente la ferritine : une ferritine normale ou haute n'exclut pas un déficit en fer (DX.6). On s'aide de la TSAT (basse ici) ou du sTfR ; en inflammation hospitalière, index sTfR/log ferritine ≥ 1,5.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'inflammation relève la ferritine.
- **B** Aucun signe de saignement aigu.
- **C** Rien n'évoque une macrocytose.
- **E** Ni ictère ni réticulocytes élevés.

③ **Perle** Maladie de Crohn : ni ferritine ni TSAT ne sont fiables, utiliser le sTfR.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_004 audité

Q79 AP DX.4 · HbA1c et fer

✅ **E** — Se fier aux glycémies

① **Pourquoi c'est juste** La carence en fer élève l'HbA1c ; anémie, hémoglobinopathie, insuffisance rénale ou grossesse la faussent (DX.4). Sans symptôme, il faut deux tests anormaux ; ici la glycémie à jeun est normale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une seule valeur sans symptôme ne suffit pas, et la carence en fer élève l'HbA1c.
- **B** Aucun diagnostic posé.
- **C** La glycémie à jeun est normale.
- **D** Elle est au contraire une option pour trancher.

③ **Perle** Traitez la carence et cherchez sa cause ; recontrôlez ensuite.

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_004 audité

Q80 EX DX.8 · hypoglycémie

✅ **B** — Glycémie pendant un épisode

① **Pourquoi c'est juste** Sueurs, tremblements, palpitations à jeun ou après l'insuline : hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire ; la glycémie pendant l'épisode tranche. Étiqueter « panique » un épisode hypoglycémique est un piège classique (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le diagnostic d'anxiété est d'exclusion.
- **C** L'horaire à jeun sous insuline oriente vers l'hypoglycémie.
- **D** Utile, mais le contexte impose d'abord la glycémie.
- **E** Traiter sans diagnostic expose au piège.

③ **Perle** Un épisode isolé peut être manqué : apprenez à la patiente à mesurer pendant la crise.

④ **Source** Phase B DX.8 §4 · LOT_004 audité

Q81 **EX** **DX.1 · bilan normal ne clôt pas**

✅ **A** — Examen complet et bilan somatique ciblé

① **Pourquoi c'est juste** Perte de poids involontaire, fièvre, sueurs nocturnes ou adénopathies orientent vers un cancer, une infection ou une maladie systémique, non vers la dépression (DX.1, DX.11) : examen complet et bilan ciblé. Début après 60 ans : la dépression tardive peut cacher une maladie organique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Perte de poids et sueurs nocturnes orientent vers une cause organique (drapeau R4).
- **C** Elle ne répond pas aux drapeaux rouges.
- **D** Un bilan de base normal n'exclut pas un cancer.
- **E** Aucun risque suicidaire ni psychose décrits.

③ **Perle** Un cancer peut aussi causer une dépression réactive.

④ **Source** Phase B DX.1 §4 · LOT_004 audité

Q82 **EX** **DX.5 · fatigue récente après 50 ans**

✅ **D** — NFS, ferritine et avis gastro-entérologique

① **Pourquoi c'est juste** Saignement digestif ou changement du transit après 50 ans, et fatigue récente progressive après 50 ans sont des drapeaux rouges de maladie somatique grave (DX.5) : NFS, ferritine, recherche de la source et avis gastro-entérologique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le méléna est un drapeau rouge à explorer sans attendre.
- **B** On ne traite pas sans chercher la source.
- **C** Elles n'explorent pas le saignement.
- **E** Aucun trouble du sommeil décrit.

③ **Perle** Instabilité ou douleur thoracique avec méléna : 144 et hospitalisation.

④ **Source** Phase B DX.5 §4 · LOT_004 audité

Q83 **EX** **DX.2 · artère normale**

✅ **D** — L'artère normale n'exclut pas l'artérite

① **Pourquoi c'est juste** Une artère temporale normale à la palpation n'exclut pas l'artérite à cellules géantes : l'imagerie ou la biopsie tranche, et le glucocorticoïde ne doit pas attendre (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie ou la biopsie tranche.
- **B** Céphalée et claudication orientent vers l'artérite.
- **C** On traite sans attendre.
- **E** L'imagerie ou la biopsie confirment.

③ **Perle** Risque : cécité par occlusion artérielle.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_004 audité

Q84 **EX** **DX.10 · fièvre persistante**

✅ **E** — Bilan infectieux avec hémocultures

① **Pourquoi c'est juste** Après une virose, une fièvre qui persiste, des frissons ou un foyer évoquent une infection non guérie ou une complication (endocardite, sepsis) : bilan infectieux, hospitalisation si instabilité (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une fièvre persistante évoque une infection non guérie ou une complication.
- **B** Le drapeau rouge doit être exploré d'abord.
- **C** On exclut d'abord une infection active.
- **D** Au plus 3 jours en automédication ; il masque la fièvre.

③ **Perle** Prendre la fièvre pour une séquelle virale est le piège.

④ **Source** Phase B DX.10 §4 · LOT_004 audité

Q85 EX DX.11 · marqueur normal

✅ **D** — Coloscopie malgré le marqueur normal

① **Pourquoi c'est juste** Un marqueur tumoral normal n'exclut pas un cancer ; il sert au suivi d'un cancer connu (DX.11). Perte de poids et sang dans les selles imposent l'endoscopie, puis biopsie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les marqueurs servent au suivi, non au dépistage.
- **B** Le délai fait perdre une chance.
- **C** On ne traite pas sans chercher la source.
- **E** Les drapeaux rouges imposent l'exploration.

③ **Perle** Dépistage organisé du côlon en Suisse : 50 à 69 ans, coloscopie tous les 10 ans ou test immunologique tous les 2 ans.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_004 audité

Q86 AP DX.3 · comportement complexe

✅ **D** — Arrêt immédiat de l'hypnotique

① **Pourquoi c'est juste** Somnambulisme, conduite ou repas au cours du sommeil sans souvenir : comportement complexe du sommeil, possible avec les hypnotiques, y compris les antagonistes de l'orexine (DX.3). Arrêt immédiat de l'hypnotique et avis neurologique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un comportement complexe du sommeil impose l'arrêt.
- **B** L'arrêt doit être immédiat.
- **C** Aggrave le risque.
- **E** Il peut aussi provoquer des comportements complexes.

③ **Perle** Le piège : poursuivre le médicament « parce qu'il aide à dormir ».

④ **Source** Phase B DX.3 §4 · LOT_004 audité

Q87 **EX** **DX.6 · femme ménopausée**

✅ **C** — Rechercher une perte de sang digestive

① **Pourquoi c'est juste** Anémie chez l'homme ou la femme ménopausée sans cause évidente : la perte de sang digestive doit être cherchée (DX.6). Attribuer l'anémie aux règles chez une femme ménopausée est un piège classique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les règles ne l'expliquent pas après la ménopause.
- **B** On cherche la cause avant de traiter.
- **D** Le VGM bas oriente vers le fer.
- **E** Le délai fait manquer un cancer digestif.

③ **Perle** Déficit en fer fréquent chez l'âgé (26,8 % dans DO-HEALTH) : cherchez une cause digestive.

④ **Source** Phase B DX.6 §4 · LOT_004 audité

Q88 **AP** **DX.9 · amaigrissement**

✅ **D** — Refuser la prescription

① **Pourquoi c'est juste** Le traitement par lévothyroxine n'a aucune indication de perte de poids ; l'AIPS l'interdit et signale un risque vital en cas d'abus (DX.9). Un surdosage donne tachycardie, arythmie, tremblement, insomnie, perte de poids.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Aucune indication chez l'euthyroïdien.
- **B** Abus : risque vital selon l'AIPS.
- **C** Pas en routine, et sans indication ici.
- **E** Ils ne posent pas d'indication de traitement.

③ **Perle** Postménopause : un surdosage chronique expose à l'ostéoporose.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_004 audité